耳鼻咽喉头颈外科学·期末题库

耳鼻咽喉头颈外科学·期末题库（batch040） 题库（200题）

> 来源：最终产物\batch040\ALL_questions_FIXED.json | 导出：2026-10-19 19:26
> 题型分布：A1×53、案例×40、判断×27、A2×27、X×26、A4×14、A3×13
> Bloom分布：理解×80、记忆×60、应用×50、分析×10

M01（12题）

1. [A1型题｜记忆] batch040-M01-A1-001

> 模块：M01｜页码：教材P11

额镜在耳鼻咽喉科检查中的主要作用是

- A. 对检查部位进行加温
- B. 对检查部位进行放大
- C. 对检查部位进行吸引
- D. 对检查部位进行喷雾
- **E. 对检查部位进行照明** ✅

答案：E

> 解析：额镜为圆形聚光凹面镜，光源投射到镜面后经反射聚焦于受检部位，检查者通过中央窥视孔观察焦点区域，其主要作用是提供照明；放大、加温、吸引与喷雾分别由显微镜、加温装置、吸引枪及喷雾枪完成（教材P11）。

---

2. [A1型题｜记忆] batch040-M01-A1-002

> 模块：M01｜页码：教材P16

中耳听骨链由外向内依次为

- A. 镫骨、砧骨、锤骨
- B. 锤骨、镫骨、砧骨
- C. 砧骨、锤骨、镫骨
- D. 砧骨、镫骨、锤骨
- **E. 锤骨、砧骨、镫骨** ✅

答案：E

> 解析：中耳听骨链依次为锤骨、砧骨、镫骨，三者连接鼓膜与前庭窗，主要作用是传递并增强声波振动（教材P16）。

---

3. [A1型题｜理解] batch040-M01-A1-003

> 模块：M01｜页码：教材P37

声音传入内耳有空气传导和骨传导两种途径，其中骨传导的特点是

- A. 需要外耳和中耳结构完整
- **B. 不依赖外耳和中耳的结构** ✅
- C. 是正常听觉的主要途径
- D. 听阈优于空气传导
- E. 经听骨链传导至卵圆窗

答案：B

> 解析：骨传导是声波经颅骨振动传入内耳，不依赖外耳和中耳的结构，是临床上判断传导性与感音神经性耳聋的重要依据；需要外耳中耳完整、听阈优于骨传导、经听骨链传导至卵圆窗均属空气传导的特点（教材P37）。

---

4. [A1型题｜理解] batch040-M01-A1-004

> 模块：M01｜页码：教材P50

林纳试验比较同侧耳气导与骨导时间，其结果判定为阳性时提示

- A. 单侧感音神经性听力损失
- B. 轻度传导性听力损失

- C. 中度混合性听力损失
- **D. 正常或感音神经性听力损失** ✅
- E. 重度传导性听力损失

答案：D

> 解析：林纳试验中气导大于骨导（AC＞BC）为阳性，见于听力正常或感音神经性听力损失；骨导大于气导（BC＞AC）为阴性，典型提示传导性听力损失，气骨导相等多见于轻中度传导性听力损失或混合性聋（教材P50）。

---

5. [A1型题｜理解] batch040-M01-A1-005

> 模块：M01｜页码：教材P50

韦伯试验中骨导偏向患耳，提示该耳为

- A. 混合性听力损失
- B. 感音神经性听力损失
- **C. 传导性听力损失** ✅
- D. 中枢性听力损失
- E. 功能性听力损失

答案：C

> 解析：韦伯试验比较两耳骨导听力，骨导偏向患耳时提示该患耳为传导性听力损失，偏向健耳则提示患耳为感音神经性听力损失，两侧相等多提示听力正常或两耳听力损失相等（教材P50）。

---

6. [A1型题｜分析] batch040-M01-A1-006

> 模块：M01｜页码：教材P50

患者主诉右耳听力下降。查体见右耳鼓膜完整、标志清晰；音叉检查示右耳林纳试验阴性，韦伯试验偏向右侧。综合上述结果，该患者最可能的诊断是

- A. 右耳感音神经性聋
- **B. 右耳传导性聋** ✅
- C. 右耳混合性聋

- D. 右耳蜗后性聋
- E. 左耳传导性聋

答案：B

> 解析：林纳试验阴性提示该耳气导小于骨导，韦伯试验偏向患侧进一步支持传导性听力损失，两项结果一致指向右耳传导性聋；若为感音神经性聋则林纳试验呈阳性、韦伯试验偏向健耳（教材P50）。

---

7. [判断题｜记忆] batch040-M01-判断-001

> 模块：M01｜页码：教材P49

纯音听阈测试属于主观听力检查方法

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：临床听力检查分为主观测听法与客观测听法，纯音听阈测试需受检者主观判断并通过反馈配合完成，属主观测听；声导抗、耳声发射及听性脑干反应无须受检者配合，属客观测听（教材P49）。

---

8. [判断题｜理解] batch040-M01-判断-002

> 模块：M01｜页码：教材P43

前庭系统主要感受头部的运动和空间位置变化，参与维持身体的平衡与姿势稳定

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：前庭系统主要感受头部的运动和空间位置变化，参与维持身体平衡与姿势稳定；其中椭圆囊斑、球囊斑感受直线加速度及重力相关位置变化，半规管壶腹嵴感受角加速度（教材P43）。

---

9. [判断题｜应用] batch040-M01-判断-003

> 模块：M01｜页码：教材P50

患者左耳听力下降，韦伯试验骨导偏向左侧，提示左耳最可能为传导性听力损失

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：韦伯试验中单侧传导性听力损失常偏向患耳，故骨导偏向左侧支持左耳传导性听力损失；若为感音神经性听力损失则骨导偏向健侧（教材P50）。

---

10. [判断题｜应用] batch040-M01-判断-004

> 模块：M01｜页码：教材P37

患者右耳气导听阈升高而骨导听阈正常，提示为感音神经性听力损失

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：气导听阈升高而骨导正常提示存在气骨导差，属传导性听力损失；感音神经性听力损失时气导与骨导听阈同时升高且无明显气骨导差（教材P37）。

---

11. [X型题｜应用] batch040-M01-X-001

> 模块：M01｜页码：教材P49

为客观评估患者的听觉传导通路功能，下列可选用的客观听力学检查有

- A. 纯音听阈测试
- **B. 声导抗测试** ✅
- **C. 耳声发射** ✅
- **D. 听性脑干反应** ✅

- E. 音叉试验

答案：BCD

> 解析：客观测听法无须受检者行为配合，包括声导抗测试、耳声发射及听性脑干反应；纯音听阈测试与音叉试验需受检者主观判断和配合，属主观测听法（教材P49）。

---

12. [X型题｜记忆] batch040-M01-X-002

> 模块：M01｜页码：教材P11

关于耳鼻咽喉科检查器械，下列描述正确的有

- **A. 额镜可将光源反射聚焦于受检部位** ✅
- **B. 硬性内镜不能弯曲、图像清晰** ✅
- **C. 软性内镜适用于张口受限患者** ✅
- **D. 压舌板用于暴露口咽部** ✅
- E. 耳内镜可直接判定听力损失类型

答案：ABCD

> 解析：额镜经反射将光源聚焦于受检部位，硬性内镜不能弯曲而图像清晰，软性内镜可弯曲、适用于张口受限或部分儿童，压舌板用于暴露口咽部；耳内镜仅能观察外耳道与鼓膜，不能直接判定听力损失类型（教材P11）。

M02（42题）

13. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-001

> 模块：M02｜页码：教材P40

前庭终末器由下列结构组成

- A. 椭圆囊斑、球囊斑和螺旋器
- B. 椭圆囊斑、球囊斑和膜蜗管
- C. 椭圆囊斑、壶腹嵴和膜蜗管
- D. 球囊斑、壶腹嵴和膜蜗管

- **E. 椭圆囊斑、球囊斑和壶腹嵴** ✅

答案：E

> 解析：前庭终末器包括椭圆囊斑、球囊斑和半规管壶腹嵴，三者共同感受头部位置与运动变化；膜蜗管、螺旋器属于耳蜗结构，负责听觉，不属前庭终末器（教材P40）。

---

14. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-002

> 模块：M02｜页码：教材P112

梅尼埃病的基本病理表现为膜迷路积水膨大，其中膨大最明显的结构是

- A. 膜蜗管和内淋巴囊
- B. 椭圆囊和壶腹
- C. 膜半规管和内淋巴囊
- **D. 膜蜗管和球囊** ✅
- E. 球囊和膜半规管

答案：D

> 解析：梅尼埃病基本病理为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显，膜半规管与内淋巴囊不膨大（教材P112）。

---

15. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-003

> 模块：M02｜页码：教材P114

梅尼埃病发作性旋转性眩晕的持续时间通常为

- A. 每次发作持续数秒钟至数十秒钟
- B. 每次发作持续数分钟至十分钟
- **C. 每次发作持续20分钟至12小时** ✅
- D. 每次发作持续约1～2天
- E. 每次发作持续约3～7天

答案：C

> 解析：梅尼埃病临床诊断标准中，发作性旋转性眩晕每次持续20分钟至12小时；临床实际多为20分钟至数小时，通常2~3小时转入缓解期，持续超过24小时者较少见（教材P114）。

---

16. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-004

> 模块：M02｜页码：教材P116

在良性阵发性位置性眩晕的四种亚型中，最常见的亚型及其占比是

- A. 后半规管BPPV，约占60%
- **B. 后半规管BPPV，约占90%** ✅
- C. 外半规管BPPV，约占90%
- D. 前半规管BPPV，约占70%
- E. 混合型BPPV，约占80%

答案：B

> 解析：按受累半规管不同，BPPV分为后半规管、外半规管、前半规管和混合型亚型，以后半规管BPPV最常见，约占90%，外半规管BPPV次之，前半规管BPPV极少（教材P116）。

---

17. [A1型题｜理解] batch040-M02-A1-005

> 模块：M02｜页码：教材P43

关于前庭终末器感受功能，下列描述正确的是

- A. 椭圆囊斑和球囊斑感受角加速度
- **B. 椭圆囊斑和球囊斑感受直线加速度** ✅
- C. 半规管壶腹嵴感受直线加速度
- D. 螺旋器感受直线加速度
- E. 椭圆囊斑和壶腹嵴感受角加速度

答案：B

> 解析：椭圆囊斑和球囊斑（耳石器官）感受直线加速度，半规管壶腹嵴感受角加速度；螺旋器为耳蜗听觉感受器，不参与前庭功能（教材P43）。

18. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-006

> 模块：M02｜页码：教材P78

耳郭化脓性软骨膜炎最多见的致病菌是

- A. 溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- **C. 铜绿假单胞菌** ✅
- D. 肺炎链球菌
- E. 变形杆菌

答案：C

> 解析：耳郭化脓性软骨膜炎常因外伤、手术、冻伤、烧伤及耳郭血肿继发感染所致，铜绿假单胞菌为最多见的致病菌，其次为金黄色葡萄球菌（教材P78）。

---

19. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-007

> 模块：M02｜页码：教材P91

诊断中耳胆脂瘤最有价值的检查是

- A. 纯音测听
- B. 声导抗测试
- **C. 颞骨CT扫描** ✅
- D. 耳内镜检查
- E. 前庭功能检查

答案：C

> 解析：诊断中耳胆脂瘤最有价值的检查是颞骨CT扫描，可发现上鼓室、鼓窦和乳突区有骨质破坏，边缘浓密整齐，并可评价听小骨破坏、面神经管及有无迷路瘘孔等（教材P91）。

---

20. [A1型题｜理解] batch040-M02-A1-008

> 模块：M02｜页码：教材P85

分泌性中耳炎鼓室积液的典型声导抗鼓室曲线是

- A. A型曲线
- B. As型曲线
- C. Ad型曲线
- **D. B型曲线** ✅
- E. C型曲线

答案：D

> 解析：平坦型（B型）声导抗图为分泌性中耳炎的典型曲线，提示鼓室积液；负压型（C型）示咽鼓管功能不良，部分有鼓室积液（教材P85）。

---

21. [A1型题｜记忆] batch040-M02-A1-009

> 模块：M02｜页码：教材P88

急性化脓性中耳炎病程超过多长时间可称为慢性化脓性中耳炎

- A. 超过2周
- B. 超过4周
- **C. 超过6～8周** ✅
- D. 超过12周
- E. 超过24周

答案：C

> 解析：急性化脓性中耳炎病程超过6～8周，可称为慢性化脓性中耳炎（教材P88）。

---

22. [A1型题｜理解] batch040-M02-A1-010

> 模块：M02｜页码：教材P112

与中枢性眩晕相比，周围性眩晕通常具有的特征是

- A. 常不伴耳鸣听力下降且眼震垂直性
- **B. 常伴耳鸣听力下降及水平旋转性眼震** ✅
- C. 常与头位改变密切相关且伴耳聋
- D. 常与头位改变无关且无耳蜗症状
- E. 常伴中枢神经系统阳性体征表现

答案：B

> 解析：周围性眩晕常突然发病，与头位变动有关，伴耳鸣、听力下降及律动性（水平或旋转性）眼震，多伴恶心、呕吐、出冷汗等自主神经症状；中枢性眩晕起病较慢，发作与头位变动无关，多不伴耳蜗症状，眼震多为垂直性（教材P112）。

---

23. [A1型题｜理解] batch040-M02-A1-011

> 模块：M02｜页码：教材P114

梅尼埃病甘油试验阳性的判断标准是服甘油后患耳

- A. 平均听阈提高10dB或以上
- **B. 平均听阈提高15dB或以上** ✅
- C. 平均听阈提高20dB或以上
- D. 平均听阈提高30dB或以上
- E. 平均听阈提高40dB或以上

答案：B

> 解析：按1.2～1.5g/kg甘油加等量生理盐水或果汁空腹饮下，服用后3小时内每小时做纯音测听，患耳平均听阈提高15dB或以上（或言语识别率提高16%以上）为阳性，有助于梅尼埃病诊断（教材P114）。

---

24. [A2型题｜应用] batch040-M02-A2-001

> 模块：M02｜页码：教材P78

患者男，32岁，1周前耳部被撞击后出现红肿，现局部红肿剧痛、明显触痛，脓肿形成后有波动感，最可能的诊断是

- A. 外耳道胆脂瘤
- B. 耳郭假性囊肿
- C. 外耳道真菌病
- D. 大疱性鼓膜炎
- **E. 耳郭化脓性软骨膜炎** ✅

答案：E

> 解析：外伤后耳郭出现红肿热痛、明显触痛，脓肿形成后有波动感，符合耳郭化脓性软骨膜炎的表现；该病为耳郭软骨膜的急性化脓性炎症，可致软骨坏死畸形（教材P78）。

---

25. [A2型题｜应用] batch040-M02-A2-002

> 模块：M02｜页码：教材P83

患者女，20岁，感冒后突发耳深部剧烈胀痛，检查见耳道深处一个紫色疱疹，内含血性液体，局部无穿孔，最可能的诊断是

- A. 特发性血鼓室
- B. 急性化脓性中耳炎
- C. 急性鼓膜炎
- **D. 大疱性鼓膜炎** ✅
- E. 分泌性中耳炎

答案：D

> 解析：发病前有感冒或流感病史，病毒感染后出现鼓膜或邻近外耳道皮肤充血、疱疹（大疱），内含血液或血浆，无鼓膜穿孔，为大疱性鼓膜炎；应与急性化脓性中耳炎早期、特发性血鼓室及蓝鼓膜鉴别（教材P83）。

---

26. [A2型题｜应用] batch040-M02-A2-003

> 模块：M02｜页码：教材P85

患儿男，6岁，感冒后出现耳闷、听力下降，检查见鼓膜内陷、呈淡黄色，声导抗为B型曲线，最可能的诊断是

- **A. 分泌性中耳炎** ✅
- B. 急性化脓性中耳炎
- C. 大疱性鼓膜炎
- D. 慢性化脓性中耳炎
- E. 外耳道胆脂瘤

答案：A

> 解析：上呼吸道感染后出现耳闷、传导性听力下降，鼓膜内陷、呈淡黄或琥珀色，声导抗呈平坦型（B型）曲线，为分泌性中耳炎的典型表现，其主要病因为咽鼓管功能障碍（教材P85）。

---

27. [A2型题｜应用] batch040-M02-A2-004

> 模块：M02｜页码：教材P114

患者女，45岁，反复发作旋转性眩晕，每次持续约1小时，伴波动性听力下降、耳鸣及耳胀满感，神志清醒，最可能的诊断是

- A. 良性位置性眩晕
- B. 前庭神经炎
- **C. 梅尼埃病** ✅
- D. 前庭药物中毒
- E. 突发性聋

答案：C

> 解析：反复发作的旋转性眩晕，持续20分钟至数小时，伴波动性听力下降、耳鸣及耳胀满感，神志清醒，符合梅尼埃病的典型症状（教材P114）。

---

28. [A2型题｜应用] batch040-M02-A2-005

> 模块：M02｜页码：教材P116

患者女，60岁，起床或翻身时出现短暂旋转性眩晕，持续约20秒钟，无耳鸣及听力下降，Dix-Hallpike试验阳性，该患者最可能受累的半规管是

- A. 外半规管

- **B. 后半规管** ✅
- C. 前半规管
- D. 上、后半规管
- E. 三个半规管

答案：B

> 解析：头位改变诱发的短暂眩晕（通常不超过1分钟）、无耳蜗症状，为良性阵发性位置性眩晕；Dix-Hallpike试验是后半规管BPPV的特异性检查，阳性提示后半规管受累（教材P116）。

---

29. [A2型题｜理解] batch040-M02-A2-006

> 模块：M02｜页码：教材P88

患者男，35岁，慢性化脓性中耳炎，经治疗流脓停止、耳内干燥后，鼓膜小的穿孔经久不愈，恰当的处理是

- A. 局部应用粉剂促进干燥
- B. 继续观察等待自愈
- C. 行乳突根治术
- D. 长期滴用氨基糖苷类滴耳液
- **E. 尽早行鼓室成形术** ✅

答案：E

> 解析：慢性化脓性中耳炎流脓停止、耳内干燥后，鼓膜小的穿孔可自愈，穿孔不愈合应及时早行鼓室成形术；局部用药忌耳毒性药物及粉剂（教材P88）。

---

30. [A3型题｜应用] batch040-M02-A3-001

> 模块：M02｜页码：教材P114

【M02-A3-组1】患者女，42岁，反复发作性旋转性眩晕3年，每次发作持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- A. 突发性聋

- B. 良性位置性眩晕
- C. 前庭神经炎
- **D. 梅尼埃病** ✅
- E. 内耳迷路炎

答案：D

> 解析：患者反复发作旋转性眩晕、每次持续20分钟以上，伴波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，神志清醒，符合梅尼埃病的典型症状及临床诊断标准（教材P114）。

---

31. [A3型题｜应用] batch040-M02-A3-002

> 模块：M02｜页码：教材P114

【M02-A3-组1】患者女，42岁，反复发作性旋转性眩晕3年，每次发作持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。 ｜ 为协助确诊，对该患者最具有诊断价值的检查是

- A. 颞骨CT扫描
- B. 耳内镜检查
- **C. 甘油试验** ✅
- D. 声导抗测试
- E. 颈部血管超声

答案：C

> 解析：梅尼埃病诊断主要依靠翔实的病史、全面的检查和仔细的鉴别诊断，甘油试验阳性有助于对本病的诊断（教材P114）。

---

32. [A3型题｜分析] batch040-M02-A3-003

> 模块：M02｜页码：教材P114

【M02-A3-组1】患者女，42岁，反复发作性旋转性眩晕3年，每次发作持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。 ｜ 该患者最近6个月内间歇期

听力最差时0.5kHz、1.0kHz及2.0kHz纯音平均听阈为50dB HL，其临床分期是

- A. 一期梅尼埃病
- B. 二期梅尼埃病
- **C. 三期梅尼埃病** ✅
- D. 四期梅尼埃病
- E. 分期依据尚不足

答案：C

> 解析：梅尼埃病根据最近6个月内间歇期听力最差时0.5kHz、1.0kHz及2.0kHz纯音的平均听阈分期：一期≤25dB HL，二期26～40dB HL，三期41～70dB HL，四期＞70dB HL；本例平均听阈50dB HL，属三期（教材P114）。

---

33. [A4型题｜应用] batch040-M02-A4-001

> 模块：M02｜页码：教材P91

【M02-A4-组1】患者男，48岁，右耳反复流脓伴恶臭多年，近半年听力明显下降，1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。｜该患者最可能的诊断是

- A. 慢性化脓性中耳炎
- **B. 中耳胆脂瘤** ✅
- C. 外耳道胆脂瘤
- D. 中耳胆固醇肉芽肿
- E. 分泌性中耳炎

答案：B

> 解析：长期耳流臭脓、听力下降，鼓膜松弛部穿孔并可见白色脱落上皮，伴同侧周围性面瘫，符合中耳胆脂瘤及其压迫或感染面神经所致的面神经麻痹（教材P91）。

---

34. [A4型题｜分析] batch040-M02-A4-002

> 模块：M02｜页码：教材P91

【M02-A4-组1】患者男，48岁，右耳反复流脓伴恶臭多年，近半年听力明显下降，1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。｜为进一步明确病变范围及骨质破坏情况，首选的检查是

- A. 声导抗测试
- B. 颅脑MRI平扫
- C. 耳内镜检查
- D. 纯音测听
- **E. 颞骨CT扫描** ✅

答案：E

> 解析：颞骨CT扫描可显示上鼓室、鼓窦和乳突区骨质破坏，并评价听小骨破坏、面神经管状况及有无迷路瘘孔，是评估中耳胆脂瘤病变范围最有价值的检查（教材P91）。

---

35. [判断题｜记忆] batch040-M02-判断-001

> 模块：M02｜页码：教材P112

梅尼埃病的基本病理表现为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显，膜半规管与内淋巴囊不膨大。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：梅尼埃病基本病理为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显，膜半规管与内淋巴囊不膨大（教材P112）。

---

36. [判断题｜记忆] batch040-M02-判断-002

> 模块：M02｜页码：教材P116

良性阵发性位置性眩晕中，后半规管BPPV最常见，约占90%。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：按受累半规管不同分为四种亚型，后半规管BPPV最常见，约占90%，外半规管BPPV次之，前半规管BPPV极少（教材P116）。

---

37. [判断题｜理解] batch040-M02-判断-003

> 模块：M02｜页码：教材P112

梅尼埃病的眩晕发作通常持续超过24小时，并可反复发作。

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：梅尼埃病眩晕每次多持续20分钟至数小时，通常2~3小时转入缓解期，持续超过24小时者较少见，故本表述错误（教材P112）。

---

38. [判断题｜理解] batch040-M02-判断-004

> 模块：M02｜页码：教材P43

前庭终末器中，椭圆囊斑和球囊斑感受角加速度，半规管壶腹嵴感受直线加速度。

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：椭圆囊斑和球囊斑感受直线加速度，半规管壶腹嵴感受角加速度，题中表述两者颠倒，故错误（教材P43）。

---

39. [判断题｜记忆] batch040-M02-判断-005

> 模块：M02｜页码：教材P91

诊断中耳胆脂瘤最有价值的检查是颞骨CT扫描，可发现上鼓室、鼓窦和乳突区骨质破坏。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：颞骨CT扫描可发现上鼓室、鼓窦和乳突区有骨质破坏，边缘浓密整齐，并可评价病变范围及听小骨破坏程度，是诊断中耳胆脂瘤最有价值的检查（教材P91）。

---

40. [X型题｜理解] batch040-M02-X-001

> 模块：M02｜页码：教材P114

关于梅尼埃病，下列描述正确的有

- **A. 属于特发性膜迷路积水的内耳病** ✅
- **B. 典型症状包括眩晕、听力下降与耳鸣** ✅
- **C. 多伴恶心呕吐、面色苍白及出冷汗** ✅
- **D. 基本病理表现为膜迷路积水膨大** ✅
- E. 甘油试验阳性无助于本病诊断

答案：ABCD

> 解析：梅尼埃病是一种特发性膜迷路积水的内耳病，典型症状为发作性眩晕、波动性听力下降、耳鸣及耳胀满感，眩晕发作时多伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗等自主神经症状，基本病理为膜迷路积水膨大；甘油试验阳性有助于本病诊断，故E错误（教材P114）。

---

41. [X型题｜理解] batch040-M02-X-002

> 模块：M02｜页码：教材P116

关于良性阵发性位置性眩晕，下列描述正确的有

- **A. 又称耳石症，是最常见的外周性前庭疾病** ✅
- **B. 眩晕由头位改变诱发，通常持续不超过1分钟** ✅
- **C. 后半规管BPPV最常见，约占90%** ✅
- **D. 部分患者继发于头部外伤或前庭神经炎** ✅

- E. 患者多有明显耳鸣及进行性听力下降

答案：ABCD

> 解析：良性阵发性位置性眩晕又名耳石症，是最常见的外周性前庭疾病，由头位改变诱发，眩晕通常持续不超过1分钟，无耳鸣及听力下降；后半规管BPPV最常见，约占90%；约半数患者病因不明，继发者最常见原因为头部外伤和前庭神经炎，故E错误（教材P116）。

---

42. [X型题｜理解] batch040-M02-X-003

> 模块：M02｜页码：教材P43

关于前庭终末器的感受功能，下列描述正确的有

- **A. 椭圆囊斑感受直线加速度** ✅
- **B. 球囊斑感受直线加速度** ✅
- **C. 半规管壶腹嵴感受角加速度** ✅
- D. 球囊斑感受角加速度
- E. 壶腹嵴感受直线加速度

答案：ABC

> 解析：椭圆囊斑和球囊斑感受直线加速度，半规管壶腹嵴感受角加速度；D、E将两者功能互换，故错误（教材P43）。

---

43. [X型题｜理解] batch040-M02-X-004

> 模块：M02｜页码：教材P91

关于中耳胆脂瘤，下列描述正确的有

- **A. 为角化鳞状上皮在中耳内形成的囊性结构** ✅
- **B. 可破坏听骨链引起传导性听力下降** ✅
- **C. 迷路骨壁破坏时可出现眩晕及瘘管试验阳性** ✅
- **D. 压迫或感染面神经可引起周围性面瘫** ✅
- E. 首选治疗方案为长期保守观察

答案：ABCD

> 解析：中耳胆脂瘤为非真性肿瘤，是角化鳞状上皮在中耳内形成的囊性结构，可破坏听骨链致传导性听力下降，迷路骨壁破坏可致眩晕、瘘管试验阳性，压迫或感染面神经可引起面神经麻痹；应尽早手术治疗，故E错误（教材P91）。

---

44. [X型题｜记忆] batch040-M02-X-005

> 模块：M02｜页码：教材P34

关于面神经分支及周围性面瘫，下列描述正确的有

- **A. 面神经在腮腺内分为颞支、颧支、颊支等分支** ✅
- **B. 周围性面瘫常见同侧额纹消失** ✅
- **C. 周围性面瘫常见同侧闭眼不全** ✅
- **D. 周围性面瘫常见口角歪斜** ✅
- E. 中枢性面瘫常见同侧额纹消失

答案：ABCD

> 解析：面神经出茎乳孔后进入腮腺，分为颞支、颧支、颊支、下颌缘支和颈支；周围性面瘫表现为同侧额纹消失、闭眼不全和口角歪斜；中枢性面瘫仅表现对侧面下部瘫痪，皱眉及闭眼功能不受影响，故E错误（教材P34）。

---

45. [案例｜记忆] batch040-M02-案例-001

> 模块：M02｜页码：教材P114

【CASE-M02-1】患者女，45岁，反复发作性眩晕3年，发作时感自身及周围物体旋转，每次持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- A. 突发性聋
- B. 良性位置性眩晕
- C. 前庭神经炎
- **D. 梅尼埃病** ✅
- E. 内耳迷路炎

答案：D

> 解析：患者反复发作旋转性眩晕，每次持续20分钟以上，伴波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，神志清醒，符合梅尼埃病的典型症状及临床诊断标准（教材P114）。

---

46. [案例｜理解] batch040-M02-案例-002

> 模块：M02｜页码：教材P112

【CASE-M02-1】患者女，45岁，反复发作性眩晕3年，发作时感自身及周围物体旋转，每次持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。 ｜ 该病的基本病理表现是

- A. 内淋巴囊显著膨大
- B. 膜迷路化脓性炎症
- **C. 膜迷路积水膨大** ✅
- D. 半规管壶腹嵴石化
- E. 鼓膜增厚钙化

答案：C

> 解析：梅尼埃病基本病理为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显，膜半规管与内淋巴囊不膨大（教材P112）。

---

47. [案例｜理解] batch040-M02-案例-003

> 模块：M02｜页码：教材P114

【CASE-M02-1】患者女，45岁，反复发作性眩晕3年，发作时感自身及周围物体旋转，每次持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。 ｜ 对本病诊断有价值的辅助检查是

- A. 颞骨CT扫描
- **B. 甘油试验** ✅
- C. 耳内镜检查

- D. 声导抗测试
- E. 前庭功能检查

答案：B

> 解析：梅尼埃病诊断主要依靠翔实的病史、全面的检查和仔细的鉴别诊断，甘油试验阳性有助于对本病的诊断（教材P114）。

---

48. [案例｜应用] batch040-M02-案例-004

> 模块：M02｜页码：教材P114

【CASE-M02-1】患者女，45岁，反复发作性眩晕3年，发作时感自身及周围物体旋转，每次持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。｜该患者的治疗原则是

- A. 单纯卧床休息并观察随访
- B. 立即行迷路切除以根治眩晕
- C. 长期口服氨基糖苷类抗生素
- D. 首选鼓膜置管引流积液
- **E. 调节自主神经、改善内耳微循环** ✅

答案：E

> 解析：梅尼埃病病因及发病机制不明，多采用以调节自主神经功能、改善内耳微循环以及减轻迷路积水为主的药物综合治疗，仅在眩晕频繁、保守治疗无效时才考虑手术（教材P114）。

---

49. [案例｜理解] batch040-M02-案例-005

> 模块：M02｜页码：教材P114

【CASE-M02-1】患者女，45岁，反复发作性眩晕3年，发作时感自身及周围物体旋转，每次持续30分钟至数小时，伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗，神志清醒；伴左耳波动性听力下降、耳鸣及耳闷胀感，发作间期听力可好转。查体鼓膜完整，纯音测听示左耳低中频感音神经性听力下降。｜该患者眩晕发作的持续时间，符合本病诊断标准的范围是

- A. 每次持续约1～3小时

- B. 每次持续数秒钟至数十秒钟
- C. 每次持续不超过1分钟
- **D. 每次持续20分钟至12小时** ✅
- E. 每次持续约3～7天

答案：D

> 解析：梅尼埃病临床诊断标准为发作性旋转性眩晕2次或2次以上，每次持续20分钟至12小时（教材P114）。

---

50. [案例｜记忆] batch040-M02-案例-006

> 模块：M02｜页码：教材P91

【CASE-M02-2】患者男，50岁，右耳反复流脓伴恶臭10余年，近1年右耳听力逐渐下降。1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，穿孔处可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。｜该患者最可能的诊断是

- A. 外耳道胆脂瘤
- B. 慢性化脓性中耳炎
- **C. 中耳胆脂瘤** ✅
- D. 中耳胆固醇肉芽肿
- E. 分泌性中耳炎

答案：C

> 解析：长期耳流臭脓、听力下降，鼓膜松弛部穿孔并可见白色脱落上皮，符合中耳胆脂瘤；胆脂瘤压迫或感染面神经可出现同侧周围性面瘫（教材P91）。

---

51. [案例｜理解] batch040-M02-案例-007

> 模块：M02｜页码：教材P91

【CASE-M02-2】患者男，50岁，右耳反复流脓伴恶臭10余年，近1年右耳听力逐渐下降。1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，穿孔处可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。｜该患者出现面瘫最可能的机制是

- A. 胆脂瘤压迫迷路引起面瘫

- **B. 胆脂瘤压迫或感染累及面神经** ✅
- C. 胆脂瘤引起颅内压增高致面瘫
- D. 中耳积液压迫面神经致面瘫
- E. 耳毒性药物损伤面神经致面瘫

答案：B

> 解析：中耳胆脂瘤压迫面神经或感染累及面神经可出现面神经麻痹，发病初期行面神经减压术预后良好（教材P91）。

---

52. [案例｜理解] batch040-M02-案例-008

> 模块：M02｜页码：教材P91

【CASE-M02-2】患者男，50岁，右耳反复流脓伴恶臭10余年，近1年右耳听力逐渐下降。1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，穿孔处可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。 ｜ 若该患者耳道加压时出现眩晕，提示

- A. 前庭神经被肿瘤侵犯
- B. 胆脂瘤压迫面神经所致
- C. 迷路发生化脓性感染
- D. 耳石脱落进入半规管
- **E. 胆脂瘤破坏迷路骨壁形成瘘孔** ✅

答案：E

> 解析：中耳胆脂瘤破坏迷路骨壁形成迷路瘘孔时，可因耳道压力改变发生眩晕、瘘管试验阳性（教材P91）。

---

53. [案例｜应用] batch040-M02-案例-009

> 模块：M02｜页码：教材P91

【CASE-M02-2】患者男，50岁，右耳反复流脓伴恶臭10余年，近1年右耳听力逐渐下降。1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，穿孔处可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。 ｜ 该患者的治疗原则是

- A. 首选鼓膜置管引流积液

- B. 长期保守观察并定期复查随访
- C. 仅口服抗生素控制感染
- **D. 尽早手术清除胆脂瘤并保护面神经** ✅
- E. 单纯行面神经减压治疗

答案：D

> 解析：中耳胆脂瘤应尽早手术治疗，手术原则为彻底清除胆脂瘤、努力保存和改善听觉功能、尽量保持外耳道生理结构与功能（教材P91）。

---

54. [案例｜理解] batch040-M02-案例-010

> 模块：M02｜页码：教材P91

【CASE-M02-2】患者男，50岁，右耳反复流脓伴恶臭10余年，近1年右耳听力逐渐下降。1个月前出现右侧口角歪斜、闭眼不全、额纹变浅。检查见右耳鼓膜松弛部穿孔，穿孔处可见白色脱落上皮及肉芽组织；纯音测听示右耳传导性听力损失。 ｜ 该患者出现周围性面瘫，发病初期行何种处理预后良好

- A. 鼓膜置管手术
- B. 迷路切除手术
- **C. 面神经减压手术** ✅
- D. 乳突根治手术
- E. 前庭康复训练

答案：C

> 解析：中耳胆脂瘤压迫或感染面神经引起面神经麻痹，发病初期行面神经减压手术预后良好（教材P91）。

M03（38题）

55. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-001

> 模块：M03｜页码：教材P158

鼻腔外侧壁下、中、上鼻甲自下而上，其大小的变化是

- A. 依次增大约1/3
- **B. 依次缩小约1/3** ✅
- C. 依次缩小约1/2
- D. 基本保持不变
- E. 依次增大约1/2

答案：B

> 解析：鼻腔外侧壁自下而上呈阶梯状排列的下、中、上鼻甲，其大小依次缩小约1/3，前端位置依次后移约1/3（教材P158）。

---

56. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-002

> 模块：M03｜页码：教材P161

生理性鼻周期表现为两侧鼻腔阻力交替变化，其变化主要与下列哪一结构的状态有关

- A. 鼻中隔偏曲程度
- B. 鼻腔筛窦引流通道状态
- **C. 双侧下鼻甲充血状态** ✅
- D. 蝶窦自然开口位置
- E. 鼻前庭鼻毛的多少

答案：C

> 解析：鼻周期是鼻阻力昼夜及左右交替变化的现象，主要受双侧下鼻甲充血状态影响，间隔2~7小时出现一个周期（教材P161）。

---

57. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-003

> 模块：M03｜页码：教材P156

鼻中隔前下部利特尔区动脉丛的组成动脉不包括****

- A. 腭大动脉

- B. 上唇动脉
- C. 筛前动脉
- D. 鼻腭动脉
- **E. 颞浅动脉** ✅

答案：E

> 解析：利特尔区由鼻腭动脉、筛前动脉、筛后动脉、上唇动脉和腭大动脉在鼻中隔前下部黏膜下交互吻合形成动脉丛，是鼻出血最常见部位；颞浅动脉属颈外动脉分支，不参与该动脉丛（教材P156）。

---

58. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-004

> 模块：M03｜页码：教材P159

后鼻孔的构成中，位于上方的是

- A. 犁骨后缘
- B. 腭骨水平部
- C. 翼突内侧板
- **D. 蝶骨体** ✅
- E. 上颌骨腭突

答案：D

> 解析：后鼻孔由蝶骨体（上）、蝶骨翼突内侧板（外）、腭骨水平部后缘（底）、犁骨的后缘（内）共同围成（教材P159）。

---

59. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-005

> 模块：M03｜页码：教材P189

鼻腔鼻窦的炎症中，最为常见的鼻窦炎症是

- A. 额窦炎
- B. 筛窦炎
- C. 蝶窦炎

- D. 全组鼻窦炎
- **E. 上颌窦炎** ✅

答案：E

> 解析：鼻腔鼻窦的炎症一般先发生在鼻腔，可一侧或双侧发生，其中上颌窦炎症最为常见，鼻窦炎也可单独孤立存在（教材P189）。

---

60. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-006

> 模块：M03｜页码：教材P189

急性鼻炎发生的首要因素是

- A. 细菌感染
- **B. 病毒感染** ✅
- C. 真菌感染
- D. 变应原接触
- E. 鼻腔异物

答案：B

> 解析：病毒感染是急性鼻炎发生的首要因素，可继发细菌感染；急性鼻炎多通过呼吸道吸入病毒引起（教材P189）。

---

61. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-007

> 模块：M03｜页码：教材P201

根据《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》，推荐鼻用糖皮质激素作为慢性鼻窦炎的一线首选治疗药物，其疗程为

- A. 不少于8周
- B. 不少于10周
- **C. 不少于12周** ✅
- D. 不少于14周
- E. 不少于16周

答案：C

> 解析：指南推荐鼻用糖皮质激素作为慢性鼻窦炎的一线首选治疗药物，疗程不少于12周；慢性鼻窦炎病程超过12周（教材P201）。

---

62. [A1型题｜理解] batch040-M03-A1-008

> 模块：M03｜页码：教材P196

变应性鼻炎的发病机制属于

- A. IgD介导的非变态反应
- B. IgG介导的 II 型变态反应
- C. IgM介导的III型变态反应
- D. IgA介导的IV型变态反应
- **E. IgE介导的 I 型变态反应** ✅

答案：E

> 解析：变应性鼻炎属IgE介导的 I 型变态反应，早发相症状主要由肥大细胞/嗜碱粒细胞脱颗粒释放的炎性介质引起（教材P196）。

---

63. [A1型题｜理解] batch040-M03-A1-009

> 模块：M03｜页码：教材P191

急性额窦炎患者常在晨起后出现头痛、中午以后逐渐缓解，其头痛的性质为

- A. 血管性头痛
- B. 紧张性头痛
- C. 神经性头痛
- D. 牵涉性头痛
- **E. 真空性头痛** ✅

答案：E

> 解析：急性额窦炎晨起后鼻腔分泌物流出堵塞鼻额管，额窦腔内产生负压甚至真空，故为真空性头痛，中午以后分泌物排空而疼痛缓解（教材P191）。

---

64. [A1型题｜理解] batch040-M03-A1-010

> 模块：M03｜页码：教材P196

色甘酸钠治疗变应性鼻炎的主要药理作用是

- A. 抑制胆碱能神经
- B. 阻断组胺受体
- C. 收缩黏膜血管
- **D. 稳定肥大细胞膜** ✅
- E. 拮抗白三烯受体

答案：D

> 解析：色甘酸钠为色酮类药物，可稳定肥大细胞膜、阻止其脱颗粒和释放介质，起效多在1周以后，故仅适用于轻症患者或预防用药（教材P196）。

---

65. [A1型题｜记忆] batch040-M03-A1-011

> 模块：M03｜页码：教材P162

鼻腔黏膜纤毛的摆动方向与频率是

- A. 朝鼻孔方向摆动，频率1000次/分
- B. 朝鼻咽部摆动，频率800次/分
- C. 朝鼻咽部摆动，频率900次/分
- **D. 朝鼻咽部摆动，频率1000次/分** ✅
- E. 朝鼻咽部摆动，频率1100次/分

答案：D

> 解析：鼻腔鼻窦黏膜大部分为假复层纤毛柱状上皮，表面约有250～300根纤毛，长度为5～10μm，直径0.3μm，每根纤毛朝鼻咽部摆动的频率是1000次/分（教材P162）。

66. [A2型题｜应用] batch040-M03-A2-001

> 模块：M03｜页码：教材P189

患者男，30岁，受凉后出现鼻塞、流黏脓涕伴右侧面部胀痛10天，鼻内镜见中鼻道脓性分泌物，鼻窦CT示右上颌窦黏膜增厚伴液平。最可能的诊断是

- A. 变应性鼻炎
- B. 慢性鼻窦炎
- **C. 急性鼻窦炎** ✅
- D. 血管运动性鼻炎
- E. 真菌球型鼻窦炎

答案：C

> 解析：受凉后鼻塞、黏脓涕及面部胀痛，鼻内镜见中鼻道脓性分泌物，符合急性鼻窦炎：初期以鼻部症状为主，鼻腔分泌物可逐渐变为黏性、黏脓性或脓性，检查还可见鼻黏膜充血肿胀（教材P189）。

---

67. [A2型题｜应用] batch040-M03-A2-002

> 模块：M03｜页码：教材P199

患者女，45岁，长期鼻塞、鼻腔干燥，鼻内镜见下鼻甲缩小、鼻腔宽大、大量干痂伴恶臭。最可能的诊断是

- A. 慢性单纯性鼻炎
- B. 慢性肥厚性鼻炎
- C. 变应性鼻炎
- **D. 萎缩性鼻炎** ✅
- E. 血管运动性鼻炎

答案：D

> 解析：鼻及鼻咽部干燥感、结痂甚至鼻出血，以及鼻塞和嗅觉减退、恶臭，为萎缩性鼻炎的典型表现；其医源性原因是下鼻甲切除过多导致鼻腔过分宽大（教材P199）。

---

68. [A2型题｜应用] batch040-M03-A2-003

> 模块：M03｜页码：教材P222

患者男，72岁，反复大量鼻出血，血液自后鼻孔流入口咽部，前鼻镜检查未发现明确出血点。出血部位最可能是

- A. 鼻中隔前下部利特尔区
- B. 中鼻道嗅裂黏膜区
- C. 下鼻道鼻泪管开口区
- D. 鼻前庭毛囊皮脂区
- **E. 鼻腔后部吴氏静脉丛** ✅

答案：E

> 解析：鼻腔后部的出血多源于动脉、出血较大且难以控制，老年人后鼻出血多见吴氏静脉丛（Woodruff）；前鼻孔填塞是较常用的有效止血方法，纱条一般不超过3～5天取出（教材P222）。

---

69. [A2型题｜应用] batch040-M03-A2-004

> 模块：M03｜页码：教材P157

患者男，25岁，鼻前庭疖肿自行挤压后出现寒战、高热，眼睑肿胀、眼球突出。最可能发生的并发症是

- A. 眶内炎性假瘤
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 硬脑膜外脓肿
- D. 颅内静脉窦血栓
- **E. 海绵窦血栓性静脉炎** ✅

答案：E

> 解析：鼻部静脉可经内眦静脉与海绵窦相通且静脉内无瓣膜，用力挤压鼻疖可使感染扩散至海绵窦，表现为寒战、高热、眼睑及结膜水肿、眼球突出固定（教材P186；静脉解剖见教材P157）。

---

70. [A2型题｜应用] batch040-M03-A2-005

> 模块：M03｜页码：教材P174

患者男，35岁，持续性鼻塞半年，鼻内镜见下鼻甲表面呈桑葚状、用减充血剂后收缩较差。最可能的诊断是

- A. 慢性单纯性鼻炎
- **B. 慢性肥厚性鼻炎** ✅
- C. 变应性鼻炎
- D. 萎缩性鼻炎
- E. 血管运动性鼻炎

答案：B

> 解析：慢性肥厚性鼻炎多表现为持续性鼻塞，下鼻甲肥厚、表面呈结节状或桑葚状，使用减充血剂后收缩较差；慢性单纯性鼻炎鼻塞呈间歇性、交替性（教材P174）。

---

71. [A3型题｜应用] batch040-M03-A3-001

> 模块：M03｜页码：教材P204

【M03-A3-组1】患者男，38岁，鼻塞、黏脓性鼻涕伴头面部胀痛反复发作1年余，近3个月症状持续加重；鼻内镜见中鼻道大量黏脓性分泌物及双侧鼻息肉，鼻窦CT示双侧上颌窦与筛窦黏膜增厚。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- A. 慢性单纯性鼻炎
- B. 慢性肥厚性鼻炎
- **C. 慢性鼻窦炎伴鼻息肉** ✅
- D. 慢性鼻窦炎不伴鼻息肉
- E. 双侧真菌球型鼻窦炎

答案：C

> 解析：鼻塞、黏性或黏脓性鼻涕为慢性鼻窦炎的主要症状，头面部胀痛与嗅觉减退为次要症状，诊断主要依据症状、查体和鼻窦CT；本例鼻内镜见双侧鼻息肉，故为慢性鼻窦炎伴鼻息肉（教材P204）。

---

72. [A3型题｜应用] batch040-M03-A3-002

> 模块：M03｜页码：教材P201

【M03-A3-组1】患者男，38岁，鼻塞、黏脓性鼻涕伴头面部胀痛反复发作1年余，近3个月症状持续加重；鼻内镜见中鼻道大量黏脓性分泌物及双侧鼻息肉，鼻窦CT示双侧上颌窦与筛窦黏膜增厚。｜根据《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》，该患者首选的一线治疗药物是

- A. 口服糖皮质激素
- B. 鼻用减充血剂
- C. 口服广谱抗生素
- D. 口服抗组胺药物
- **E. 鼻用糖皮质激素** ✅

答案：E

> 解析：指南推荐鼻用糖皮质激素作为慢性鼻窦炎的一线首选治疗药物，疗程不少于12周（教材P201）。

---

73. [A3型题｜应用] batch040-M03-A3-003

> 模块：M03｜页码：教材P204

【M03-A3-组1】患者男，38岁，鼻塞、黏脓性鼻涕伴头面部胀痛反复发作1年余，近3个月症状持续加重；鼻内镜见中鼻道大量黏脓性分泌物及双侧鼻息肉，鼻窦CT示双侧上颌窦与筛窦黏膜增厚。｜该患者经规范药物治疗后症状无明显改善，下一步最恰当的处理是

- A. 继续原方案药物治疗并复查鼻窦CT
- B. 改为口服糖皮质激素
- **C. 行功能性鼻内镜鼻窦手术** ✅
- D. 鼻内镜下鼻窦穿刺冲洗
- E. 加用抗组胺药物治疗

答案：C

> 解析：功能性鼻内镜鼻窦手术（FESS）在鼻内镜下切除鼻息肉、开放鼻窦，纠正鼻腔解剖学异常，尽可能保留鼻窦黏膜并重建鼻腔鼻窦通气引流，适用于规范药物治疗效果不佳的慢性鼻窦炎（教材P204）。

---

74. [A4型题｜应用] batch040-M03-A4-001

> 模块：M03｜页码：教材P196

【M03-A4-组1】患儿男，6岁，反复发作性喷嚏、清水样鼻涕伴鼻痒2年，每遇尘螨及花粉季节加重，伴眼痒、流泪；鼻内镜见鼻黏膜苍白水肿，变应原皮肤点刺试验阳性。｜该患儿最可能的诊断是

- A. 急性鼻炎
- **B. 变应性鼻炎** ✅
- C. 血管运动性鼻炎
- D. 萎缩性鼻炎
- E. 慢性单纯性鼻炎

答案：B

> 解析：变应性鼻炎以鼻痒、阵发性连续喷嚏、大量水样鼻涕和鼻塞为临床主要特征，诊断主要依靠病史、典型症状体征及特异性变应原检查（教材P196）。

---

75. [A4型题｜应用] batch040-M03-A4-002

> 模块：M03｜页码：教材P196

【M03-A4-组1】患儿男，6岁，反复发作性喷嚏、清水样鼻涕伴鼻痒2年，每遇尘螨及花粉季节加重，伴眼痒、流泪；鼻内镜见鼻黏膜苍白水肿，变应原皮肤点刺试验阳性。｜该患儿症状发作的早发相主要由哪两种细胞脱颗粒释放炎症介质所致

- A. 嗜酸性粒细胞与上皮细胞
- B. 嗜酸性粒细胞与中性粒细胞
- **C. 肥大细胞与嗜碱粒细胞** ✅
- D. 上皮细胞与杯状细胞
- E. 杯状细胞与纤毛细胞

答案：C

> 解析：变应性鼻炎早发相症状发生于与变应原接触的数分钟内，主要由肥大细胞/嗜碱粒细胞脱颗粒释放的炎性介质引起（教材P196）。

---

76. [A4型题｜分析] batch040-M03-A4-003

> 模块：M03｜页码：教材P196

【M03-A4-组1】患儿男，6岁，反复发作性喷嚏、清水样鼻涕伴鼻痒2年，每遇尘螨及花粉季节加重，伴眼痒、流泪；鼻内镜见鼻黏膜苍白水肿，变应原皮肤点刺试验阳性。｜关于该患儿的诊治，下列处理不恰当的是

- A. 嘱患者避免接触尘螨与花粉
- B. 首选鼻用糖皮质激素治疗
- **C. 予以长期口服抗生素治疗** ✅
- D. 症状控制后逐步降级用药
- E. 合并哮喘时需上下气道同治

答案：C

> 解析：变应性鼻炎以鼻用糖皮质激素等药物治疗为主，无细菌感染证据时长期口服抗生素并无指征；同时应避免接触变应原，合并哮喘者需上下气道同治（教材P196）。

---

77. [判断题｜记忆] batch040-M03-判断-001

> 模块：M03｜页码：教材P161

正常人的鼻阻力呈昼夜及左右规律交替变化，主要受双侧下鼻甲充血状态影响，间隔2~7小时出现一个周期，称为生理性鼻周期。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：鼻周期为双侧下鼻甲充血状态交替所致，无鼻周期时患者可主诉双侧间歇性鼻塞，且卧位时加重，故夜间鼻塞更明显（教材P161）。

---

78. [判断题｜记忆] batch040-M03-判断-002

> 模块：M03｜页码：教材P201

慢性鼻窦炎的病程超过12周；推荐鼻用糖皮质激素作为一线首选治疗药物，疗程不少于12周。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：据《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》，慢性鼻窦炎病程超过12周，鼻用糖皮质激素疗程不少于12周（教材P201）。

---

79. [判断题｜记忆] batch040-M03-判断-003

> 模块：M03｜页码：教材P201

儿童慢性鼻窦炎患者的手术指征可适当放宽，8岁以上即可常规手术治疗。

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：儿童慢性鼻窦炎的手术指征需严格把握，12岁以下原则上不宜手术（教材P201）。

---

80. [判断题｜理解] batch040-M03-判断-004

> 模块：M03｜页码：教材P155

窦口鼻道复合体（OMC）涉及上颌窦、前组筛窦及额窦的引流通道，不包括**蝶窦自然开口。**

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：OMC是前组鼻窦引流的重要区域，涉及中鼻道、筛漏斗、半月裂及上颌窦、前组筛窦和额窦的相关引流通道，不包括蝶窦自然开口；后组筛窦开口于上鼻道，蝶窦开口于蝶筛隐窝（教材P155）。

---

81. [判断题｜理解] batch040-M03-判断-005

> 模块：M03｜页码：教材P186

鼻疖多位于鼻前庭，治疗时应尽早挤压脓栓以促进引流。

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：鼻疖治疗原则为严禁挤压、控制感染、预防并发症；挤压可使感染经内眦静脉扩散至海绵窦，引起海绵窦血栓性静脉炎（教材P186）。

---

82. [判断题｜理解] batch040-M03-判断-006

> 模块：M03｜页码：教材P157

外鼻静脉可经内眦静脉与海绵窦相通，且静脉内无瓣膜、血流可双向流动，故鼻部疖肿挤压后可引起颅内并发症。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：外鼻静脉经内眦静脉、面静脉汇入颈内静脉，内眦静脉可经眼上、眼下静脉与海绵窦相通，静脉内无瓣膜使血液双向流动，故鼻部感染挤压可致海绵窦栓塞等颅内并发症（教材P157）。

---

83. [X型题｜理解] batch040-M03-X-001

> 模块：M03｜页码：教材P191

急性鼻窦炎的临床表现可包括

- **A. 鼻塞与脓性分泌物** ✅
- **B. 头痛或局部疼痛** ✅
- C. 胸闷与咯血

- **D. 嗅觉减退** ✅
- **E. 畏寒发热** ✅

答案：ABDE

> 解析：急性鼻窦炎局部症状为鼻塞、脓性分泌物、头痛或局部疼痛、嗅觉减退，全身症状为畏寒发热、恶心呕吐及消化道症状；胸闷与咯血不属其表现（教材P191）。

---

84. [X型题｜理解] batch040-M03-X-002

> 模块：M03｜页码：教材P222

可用于鼻出血评估的检查有

- **A. 前鼻镜检查** ✅
- **B. 鼻内镜检查** ✅
- **C. DSA或CTA** ✅
- D. 纤维喉镜检查
- **E. 血常规检查** ✅

答案：ABCE

> 解析：DSA或CTA、前鼻镜检查、鼻内镜检查、血常规等可用于鼻出血评估；条件允许时可采用鼻内镜检查并止血，纤维喉镜用于喉部检查（教材P222）。

---

85. [X型题｜理解] batch040-M03-X-003

> 模块：M03｜页码：教材P189

需要与急性鼻炎相鉴别的疾病有

- **A. 流行性感冒** ✅
- B. 急性化脓性中耳炎
- **C. 变应性鼻炎** ✅
- **D. 血管运动性鼻炎** ✅
- **E. 急性传染病** ✅

答案：ACDE

> 解析：需与急性鼻炎鉴别的有流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎及急性传染病等；急性化脓性中耳炎是急性鼻炎向邻近组织扩散引起的并发症而非鉴别疾病（教材P189）。

---

86. [X型题｜理解] batch040-M03-X-004

> 模块：M03｜页码：教材P199

萎缩性鼻炎的临床表现有

- A. 阵发性连续喷嚏
- **B. 鼻及鼻咽部干燥感** ✅
- **C. 鼻塞和嗅觉减退** ✅
- **D. 头痛与头昏** ✅
- **E. 鼻腔恶臭** ✅

答案：BCDE

> 解析：萎缩性鼻炎可见鼻及鼻咽部干燥感、鼻塞和嗅觉减退或失嗅、头痛头昏及呼气恶臭等表现；阵发性连续喷嚏为变应性鼻炎特征（教材P199）。

---

87. [X型题｜理解] batch040-M03-X-005

> 模块：M03｜页码：教材P196

变应性鼻炎的主要临床特征有

- **A. 鼻腔瘙痒** ✅
- **B. 阵发性连续喷嚏** ✅
- **C. 大量水样鼻涕** ✅
- **D. 鼻腔堵塞** ✅
- E. 脓性鼻涕

答案：ABCD

> 解析：变应性鼻炎以鼻痒、阵发性连续喷嚏、大量水样鼻涕和鼻塞为临床主要特征，部分患者尚有嗅觉减退；脓性鼻涕多提示感染（教材P196）。

---

88. [案例｜理解] batch040-M03-案例-001

> 模块：M03｜页码：教材P216

【CASE-M03-1】患儿男，7岁，1周前诊断为急性鼻窦炎，近2天出现左眼睑红肿、眼球突出、眼球活动受限，伴发热；查体见左眼睑明显红肿、眼球向外转动受限。｜该患儿最可能发生的并发症是

- A. 眶周蜂窝织炎
- **B. 眶内蜂窝织炎** ✅
- C. 眶壁骨膜下脓肿
- D. 眶内脓肿
- E. 球后视神经炎

答案：B

> 解析：眶内蜂窝织炎为严重的鼻源性眶内并发症，表现为眼球突出明显、运动受限、视力明显减退、球结膜水肿和眶深部剧痛，另有高热等全身症状；眶周蜂窝织炎则无眼球运动受限与突出（教材P216）。

---

89. [案例｜理解] batch040-M03-案例-002

> 模块：M03｜页码：教材P159

【CASE-M03-1】患儿男，7岁，1周前诊断为急性鼻窦炎，近2天出现左眼睑红肿、眼球突出、眼球活动受限，伴发热；查体见左眼睑明显红肿、眼球向外转动受限。｜该患儿感染由鼻窦扩散至眼眶，其解剖学基础是

- A. 上颌窦与眼眶仅隔薄纸样板
- B. 蝶窦与眼眶仅隔薄纸样板
- C. 额窦与眼眶仅隔薄纸样板
- **D. 筛窦与眼眶仅隔薄纸样板** ✅
- E. 鼻泪管与眼眶仅隔薄纸样板

答案：D

> 解析：筛窦与眼眶内侧壁之间仅隔薄的纸样板，故筛窦炎症易波及眼眶引起眶内炎性并发症，儿童急性鼻窦炎尤其需警惕（教材P159）。

---

90. [案例｜理解] batch040-M03-案例-003

> 模块：M03｜页码：教材P217

【CASE-M03-1】患儿男，7岁，1周前诊断为急性鼻窦炎，近2天出现左眼睑红肿、眼球突出、眼球活动受限，伴发热；查体见左眼睑明显红肿、眼球向外转动受限。 ｜ 提示该患儿可能发生眶内并发症、需紧急处理的表现是

- A. 咽痛伴吞咽困难与发热
- B. 眼睑红肿伴低热乏力
- C. 鼻腔少量渗血伴鼻塞
- D. 单侧耳闷伴传导性听力下降
- **E. 眶深部剧痛与视力显著减退** ✅

答案：E

> 解析：视力下降和眼球活动障碍是鼻源性眶内并发症的重要危险信号；眶内蜂窝织炎可见球结膜水肿、眶深部剧痛，提示病情较重需及时处理（教材P217）。

---

91. [案例｜理解] batch040-M03-案例-004

> 模块：M03｜页码：教材P216

【CASE-M03-1】患儿男，7岁，1周前诊断为急性鼻窦炎，近2天出现左眼睑红肿、眼球突出、眼球活动受限，伴发热；查体见左眼睑明显红肿、眼球向外转动受限。 ｜ 为明确眶内并发症的类型与范围，首选的影像学检查是

- A. 鼻窦MRI平扫检查
- B. 眼眶X线平片检查
- C. 眼部彩色多普勒超声
- **D. 眼眶及鼻窦增强CT** ✅
- E. 眼眶CT平扫检查

答案：D

> 解析：眼眶、颅底与鼻腔鼻窦解剖关系密切，鼻源性眶内并发症需结合临床及增强CT或MRI鉴别，增强CT可同时显示鼻窦炎症与眼眶病变范围（教材P216）。

---

92. [案例｜分析] batch040-M03-案例-005

> 模块：M03｜页码：教材P217

【CASE-M03-1】患儿男，7岁，1周前诊断为急性鼻窦炎，近2天出现左眼睑红肿、眼球突出、眼球活动受限，伴发热；查体见左眼睑明显红肿、眼球向外转动受限。 ｜ 该患儿当前恰当的处理原则包括

- **A. 尽早足量静脉使用抗生素** ✅
- B. 首选口服抗组胺药控制症状
- **C. 控制感染并改善鼻窦引流** ✅
- **D. 密切观察视力与眼球活动** ✅
- E. 立即行鼻息肉切除术

答案：ACD

> 解析：鼻源性眶内并发症的治疗原则为早期积极抗感染、抗炎治疗及鼻腔鼻窦通畅引流，脓肿形成者需切开引流，必要时行鼻窦开放术并请眼科协同处理；本例为急性感染，抗组胺药与鼻息肉切除术均非当前处理（教材P217；治疗原则见教材P191）。

M04（28题）

93. [A1型题｜记忆] batch040-M04-A1-001

> 模块：M04｜页码：教材P248

喉咽（下咽）后壁平对的颈椎范围是

- A. 第1～2颈椎
- B. 第2～4颈椎
- **C. 第3～6颈椎** ✅
- D. 第4～7颈椎
- E. 第5～7颈椎

答案：C

> 解析：喉咽又称下咽，位于会厌上缘平面与环状软骨下缘平面之间，向下连接食管，其后壁平对第3～6颈椎；咽的底部约平第6颈椎（教材P248）。

---

94. [A1型题｜记忆] batch040-M04-A1-002

> 模块：M04｜页码：教材P251

穿行于咽旁间隙后隙（神经血管隙）的脑神经组合是

- A. 三叉神经、面神经、舌咽神经、迷走神经
- **B. 舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经** ✅
- C. 面神经、前庭蜗神经、舌咽神经、副神经
- D. 迷走神经、舌下神经、副神经、三叉神经
- E. 舌咽神经、副神经、面神经、前庭蜗神经

答案：B

> 解析：咽旁间隙后隙内有颈内动脉、颈内静脉、舌咽神经、迷走神经、舌下神经、副神经及交感神经干等通过，其脑神经可用口诀「舌舌副迷走」记忆，即舌咽神经、舌下神经、副神经、迷走神经；三叉神经、面神经、前庭蜗神经并不穿行此隙（教材P251）。

---

95. [A1型题｜记忆] batch040-M04-A1-003

> 模块：M04｜页码：教材P251

Waldeyer环内环的组成不包括**下列哪项**

- A. 咽扁桃体
- B. 咽鼓管扁桃体
- C. 腭扁桃体
- D. 咽后壁淋巴滤泡
- **E. 颈深上淋巴结** ✅

答案：E

> 解析：咽淋巴环内环主要由咽扁桃体（腺样体）、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡及舌扁桃体构成，即口诀「上咽鼓，两侧腭，下舌旁」；颈深上淋巴结属于颈部的淋巴组织，不构成内环（教材P251）。

---

96. [A1型题｜记忆] batch040-M04-A1-004

> 模块：M04｜页码：教材P260

急性扁桃体炎的抗生素治疗，首选药物是

- A. 庆大霉素
- B. 红霉素
- **C. 青霉素** ✅
- D. 甲硝唑
- E. 氯霉素

答案：C

> 解析：急性扁桃体炎的主要致病菌为乙型溶血性链球菌，抗生素应用为其主要治疗方法，首选青霉素；红霉素、庆大霉素、氯霉素等抗菌谱与毒性各异，不作首选（教材P260）。

---

97. [A1型题｜记忆] batch040-M04-A1-005

> 模块：M04｜页码：教材P266

腺样体的生理性肥大期是

- A. 出生至1岁
- **B. 2～6岁** ✅
- C. 6～10岁
- D. 10～14岁
- E. 14岁以后

答案：B

> 解析：腺样体出生时即存在，2～6岁是增生旺盛时期，为腺样体的生理性肥大期，10岁以后逐渐萎缩，成人则大部分消失（教材P266）。

98. [A1型题｜记忆] batch040-M04-A1-006

> 模块：M04｜页码：教材P266

根据腺样体肥大分度，IV度是指腺样体阻塞鼻后孔超过

- A. 25%
- B. 50%
- C. 60%
- **D. 75%** ✅
- E. 80%

答案：D

> 解析：腺样体肥大分为四度：Ⅰ度阻塞鼻后孔≤25%，Ⅱ度26%～50%，Ⅲ度51%～75%，Ⅳ度>75%（教材P266）。

---

99. [A1型题｜理解] batch040-M04-A1-007

> 模块：M04｜页码：教材P277

鼻咽纤维血管瘤动脉血供的最主要来源是

- A. 面动脉
- **B. 上颌动脉** ✅
- C. 咽升动脉
- D. 舌动脉
- E. 甲状腺上动脉

答案：B

> 解析：鼻咽纤维血管瘤的动脉血供多来源于上颌动脉，是其最主要来源；肿瘤生长迅速，周围还可有来自面动脉、蝶腭动脉、腭大动脉、枕动脉等的辅助血供（教材P277）。

---

100. [A1型题｜理解] batch040-M04-A1-008

> 模块：M04｜页码：教材P282

喉咽恶性肿瘤患者就诊时多已属中晚期，导致其延误诊治的原因是

- A. 肿瘤生长极为缓慢
- **B. 早期缺乏特异性表现** ✅
- C. 咽部淋巴回流丰富
- D. 患者咽反射迟钝
- E. 肿瘤多为良性病变

答案：B

> 解析：喉咽肿瘤早期常无明显症状，容易被忽视，导致就诊时多为中晚期；其晚期常见症状为吞咽困难、颈部淋巴结肿大，部分病例出现声音嘶哑，咽痛较轻或不明显（教材P282）。

---

101. [A2型题｜理解] batch040-M04-A2-001

> 模块：M04｜页码：教材P266

患儿，5岁，突发高热、鼻塞严重并张口呼吸2天，伴耳内闷胀感；纤维鼻咽镜检查见腺样体充血肿大、表面覆有渗出物。该患儿最可能的诊断是

- A. 急性中耳炎
- B. 腺样体肥大
- C. 急性扁桃体炎
- D. 急性鼻窦炎
- **E. 急性腺样体炎** ✅

答案：E

> 解析：急性腺样体炎为儿童常见疾病，以3～10岁多见，常继发于急性上呼吸道感染，表现为突发高热、鼻咽部隐痛、鼻塞严重与张口呼吸，检查可见腺样体充血肿大、表面覆有渗出物；本例5岁患儿起病急、高热伴腺样体充血肿大，符合急性腺样体炎（教材P266）。

---

102. [A2型题｜理解] batch040-M04-A2-002

> 模块：M04｜页码：教材P269

患者，30岁，因急性扁桃体炎治疗4天后右侧咽痛加剧、吞咽困难、言语含糊、张口受限；查体见悬雍垂水肿并偏向左侧。该患者最可能的诊断是

- A. 急性扁桃体炎
- **B. 扁桃体周脓肿** ✅
- C. 咽旁脓肿
- D. 咽后脓肿
- E. 扁桃体肿瘤

答案：B

> 解析：扁桃体周脓肿常继发于急性扁桃体炎，表现为一侧咽痛加剧、吞咽困难、言语含糊、张口受限，检查见患侧腭舌弓及软腭红肿突出、悬雍垂水肿偏向对侧，穿刺抽出脓液即可确诊（教材P269）。

---

103. [A2型题｜理解] batch040-M04-A2-003

> 模块：M04｜页码：教材P260

患者，22岁，咽痛、发热3天，查体见双侧腭扁桃体红肿、表面有黄白色脓点，血常规示白细胞及中性粒细胞升高。该患者最可能的诊断是

- A. 扁桃体角化症
- B. 慢性扁桃体炎
- C. 扁桃体周脓肿
- **D. 急性扁桃体炎** ✅
- E. 樊尚咽峡炎

答案：D

> 解析：急性扁桃体炎表现为咽痛、吞咽痛、发热及扁桃体充血肿大，可有脓点，血常规白细胞及中性粒细胞升高支持细菌感染；慢性扁桃体炎多为反复发作史、症状轻微，扁桃体周脓肿为单侧、张口受限，扁桃体角化症表面为白色砂粒样物（教材P260）。

---

104. [A2型题｜应用] batch040-M04-A2-004

> 模块：M04｜页码：教材P277

患者，17岁，男性，反复鼻出血伴右侧鼻塞6个月；鼻内镜检查见鼻咽部红色、表面光滑、触之易出血的新生物，CT示瘤体位于鼻咽部。该患者最可能的诊断是

- A. 鼻咽部脊索瘤
- B. 鼻咽部恶性肿瘤
- **C. 鼻咽纤维血管瘤** ✅
- D. 鼻后孔出血性息肉
- E. 腺样体肥大

答案：C

> 解析：鼻咽纤维血管瘤为鼻咽部最常见的良性肿瘤，好发于10～25岁青年男性，以反复鼻出血和鼻塞为主要表现，鼻咽镜下呈圆形或分叶状红色肿瘤、表面光滑且富有血管（教材P277）。

---

105. [判断题｜记忆] batch040-M04-判断-001

> 模块：M04｜页码：教材P253

咽不仅为呼吸与消化的共同通道，还具有调节中耳气压的功能

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：咽为呼吸与消化的共同通道，具有呼吸功能、言语形成、吞咽功能、防御保护功能、调节中耳气压功能及扁桃体的免疫功能（教材P253）。

---

106. [判断题｜理解] batch040-M04-判断-002

> 模块：M04｜页码：教材P251

咽淋巴环是上呼吸道的免疫防线，参与病原体的识别与免疫应答

- **A. 该表述正确** ✅

- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：咽黏膜下淋巴组织丰富，较大淋巴组织团块呈环状排列构成咽淋巴环，是上呼吸道免疫防线，参与病原体识别与免疫应答（教材P251）。

---

107. [判断题｜应用] batch040-M04-判断-003

> 模块：M04｜页码：教材P269

前上型扁桃体周围脓肿患者，查体可见悬雍垂水肿并偏向患侧

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：前上型扁桃体周脓肿时患侧腭舌弓及软腭红肿突出，扁桃体被推向下方，悬雍垂水肿并偏向对侧（健侧）而非偏向患侧，故该表述错误（教材P269）。

---

108. [判断题｜理解] batch040-M04-判断-004

> 模块：M04｜页码：教材P281

扁桃体恶性肿瘤中，鳞状细胞癌是最常见的病理类型

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：口咽区的扁桃体上皮覆盖为复层鳞状上皮，容易发生鳞状上皮恶变，扁桃体恶性肿瘤中鳞状细胞癌最常见，故在口咽肿瘤评估中应优先考虑（教材P281）。

---

109. [X型题｜记忆] batch040-M04-X-001

> 模块：M04｜页码：教材P253

咽的生理功能包括

- **A. 呼吸功能** ✅
- **B. 言语形成** ✅
- **C. 吞咽功能** ✅
- **D. 调节中耳气压** ✅
- E. 分泌胰岛素

答案：ABCD

> 解析：咽为呼吸与消化的共同通道，具有呼吸功能、言语形成、吞咽功能、防御保护功能、调节中耳气压功能及扁桃体的免疫功能；分泌胰岛素为胰腺内分泌功能，与咽无关（教材P253）。

---

110. [X型题｜理解] batch040-M04-X-002

> 模块：M04｜页码：教材P262

关于慢性扁桃体炎，下列描述正确的有

- **A. 多由急性扁桃体炎反复发作引起** ✅
- **B. 链球菌和葡萄球菌为主要致病菌** ✅
- C. 扁桃体大小可反映炎症程度
- **D. 可成为引起其他脏器病变的病灶** ✅
- **E. 扁桃体切除术后可并发出血** ✅

答案：ABDE

> 解析：慢性扁桃体炎多由急性扁桃体炎反复发作或扁桃体隐窝引流不畅演变而来，主要致病菌为链球菌和葡萄球菌，可成为全身感染病灶；扁桃体大小并不表明其炎症程度，不能据此诊断；扁桃体切除术后并发症包括出血、伤口感染和肺部并发症（教材P262）。

---

111. [X型题｜应用] batch040-M04-X-003

> 模块：M04｜页码：教材P270

扁桃体周围脓肿形成后，可采取的处理措施包括

- **A. 穿刺抽脓** ✅
- **B. 切开排脓** ✅
- **C. 患侧扁桃体切除** ✅
- **D. 足量抗生素治疗** ✅
- E. 立即行气管切开

答案：ABCD

> 解析：扁桃体周脓肿形成后可行穿刺抽脓、切开排脓，并在抗生素有效控制下施行患侧扁桃体切除，同时需足量抗生素控制感染；气管切开并非常规处理，仅在并发明显喉阻塞时考虑（教材P270）。

---

112. [A3型题｜理解] batch040-M04-A3-001

> 模块：M04｜页码：教材P282

【M04-A3-组1】患者，52岁，男性，咽部异物感及吞咽哽噎感2月余，进行性加重，伴同侧耳痛、痰中带血；查体见左侧颈部淋巴结肿大，质硬。纤维喉镜检查见梨状窝区黏膜水肿、饱满。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- A. 急性会厌炎
- B. 慢性咽炎
- C. 扁桃体周脓肿
- D. 咽异感症
- **E. 喉咽恶性肿瘤** ✅

答案：E

> 解析：喉咽恶性肿瘤好发于梨状窝，早期症状不明显，进展后可出现进行性吞咽困难、颈部淋巴结肿大及痰中带血，伴同侧放射性耳痛；本例中年男性、进行性吞咽哽噎伴梨状窝区病变与颈部质硬淋巴结，符合喉咽恶性肿瘤（教材P282）。

---

113. [A3型题｜应用] batch040-M04-A3-002

> 模块：M04｜页码：教材P282

【M04-A3-组1】患者，52岁，男性，咽部异物感及吞咽哽噎感2月余，进行性加重，伴同侧耳痛、痰中带血；查体见左侧颈部淋巴结肿大，质硬。纤维喉镜检查见梨状窝区黏膜水肿、饱满。 ｜ 为明确诊断，对该患者最有价值的检查是

- **A. 病理活组织检查** ✅
- B. 颈部B超检查
- C. 咽部X线检查
- D. 血常规检查
- E. 喉动态镜检查

答案：A

> 解析：喉咽恶性肿瘤早期症状不显著，推荐纤维/电子/NBI喉镜检查发现可疑病变后及时行病理学检查以明确诊断；B超、X线、血常规与喉动态镜均不能替代组织病理（教材P282）。

---

114. [A4型题｜理解] batch040-M04-A4-001

> 模块：M04｜页码：教材P266

【M04-A4-组1】患儿，4岁，睡眠打鼾、张口呼吸1年余，家长发现其表情呆滞、上唇翘起；鼻咽镜检查示鼻咽顶后壁淋巴组织增生，阻塞鼻后孔约80%。 ｜ 该患儿腺样体肥大的分度是

- A. Ⅰ度肥大
- B. Ⅱ度肥大
- C. Ⅲ度肥大
- **D. Ⅳ度肥大** ✅
- E. 未达肥大标准

答案：D

> 解析：腺样体肥大分为四度：Ⅰ度阻塞鼻后孔≤25%，Ⅱ度26%～50%，Ⅲ度51%～75%，Ⅳ度>75%；该患儿阻塞约80%，超过75%，属Ⅳ度肥大（教材P266）。

---

115. [A4型题｜应用] batch040-M04-A4-002

> 模块：M04｜页码：教材P266

【M04-A4-组1】患儿，4岁，睡眠打鼾、张口呼吸1年余，家长发现其表情呆滞、上唇翘起；鼻咽镜检查示鼻咽顶后壁淋巴组织增生，阻塞鼻后孔约80%。 ｜ 若该患儿保守治疗效果不佳，宜采取的治疗措施是

- A. 鼓膜置管术
- B. 扁桃体切除术
- C. 鼻中隔矫正术
- **D. 腺样体切除术** ✅
- E. 气管切开术

答案：D

> 解析：腺样体肥大引起气道梗阻尤其是儿童阻塞性睡眠呼吸暂停时，若保守治疗无效，应尽早经口或鼻内镜行腺样体切除术；扁桃体切除术、鼻中隔矫正术、鼓膜置管术及气管切开术均非本例的首选（教材P266）。

---

116. [案例｜理解] batch040-M04-案例-001

> 模块：M04｜页码：教材P269

【CASE-M04-1】患者，28岁，男性，因急性扁桃体炎治疗5天后出现右侧咽痛加剧、吞咽困难、流涎、言语含糊不清、张口受限；查体见急性病容，右侧腭舌弓及软腭红肿隆起，悬雍垂水肿偏向左侧，右侧扁桃体被推向内下方。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- A. 急性扁桃体炎
- **B. 扁桃体周脓肿** ✅
- C. 咽旁脓肿
- D. 咽后脓肿
- E. 第3磨牙冠周炎

答案：B

> 解析：扁桃体周脓肿常继发于急性扁桃体炎，突出表现为一侧咽痛加剧、吞咽困难、流涎、言语含糊、张口受限，查体见患侧腭舌弓及软腭红肿隆起、悬雍垂水肿偏向对侧（本例偏向左侧）、扁桃体被推向内下方（教材P269）。

117. [案例｜应用] batch040-M04-案例-002

> 模块：M04｜页码：教材P269

【CASE-M04-1】患者，28岁，男性，因急性扁桃体炎治疗5天后出现右侧咽痛加剧、吞咽困难、流涎、言语含糊不清、张口受限；查体见急性病容，右侧腭舌弓及软腭红肿隆起，悬雍垂水肿偏向左侧，右侧扁桃体被推向内下方。｜为确定诊断，对该患者最有价值的检查是

- A. 咽拭子培养
- B. 咽部CT扫描
- C. 颈部B超检查
- D. 血常规检查
- **E. 脓肿穿刺抽脓** ✅

答案：E

> 解析：扁桃体周脓肿根据病史及查体诊断不难，穿刺抽出脓液即可确定诊断；超声有助于鉴别扁桃体周炎与扁桃体周脓肿，但穿刺抽脓为确诊依据（教材P269）。

---

118. [案例｜应用] batch040-M04-案例-003

> 模块：M04｜页码：教材P269

【CASE-M04-1】患者，28岁，男性，因急性扁桃体炎治疗5天后出现右侧咽痛加剧、吞咽困难、流涎、言语含糊不清、张口受限；查体见急性病容，右侧腭舌弓及软腭红肿隆起，悬雍垂水肿偏向左侧，右侧扁桃体被推向内下方。｜该患者扁桃体周脓肿最可能的分型是

- A. 咽旁型
- B. 后上型
- C. 咽后型
- **D. 前上型** ✅
- E. 混合型

答案：D

> 解析：扁桃体周脓肿多单侧发病，按部位分前上型与后上型，前者多见，脓肿位于扁桃体上极与腭舌弓之间，表现为患侧腭舌弓及软腭红肿突出、悬雍垂水肿偏向对侧、扁桃体被推向下方；本例正符合前上型（教材P269）。

119. [案例｜分析] batch040-M04-案例-004

> 模块：M04｜页码：教材P269

【CASE-M04-1】患者，28岁，男性，因急性扁桃体炎治疗5天后出现右侧咽痛加剧、吞咽困难、流涎、言语含糊不清、张口受限；查体见急性病容，右侧腭舌弓及软腭红肿隆起，悬雍垂水肿偏向左侧，右侧扁桃体被推向内下方。｜该患者应与下列哪些疾病相鉴别

- **A. 咽旁间隙脓肿** ✅
- **B. 咽后间隙脓肿** ✅
- **C. 第3磨牙冠周炎** ✅
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 急性会厌炎

答案：ABC

> 解析：扁桃体周脓肿需与咽旁脓肿（患侧扁桃体及咽侧壁被推向对侧、扁桃体本身无病变）、咽后脓肿（多见于幼儿、咽后壁隆起）及第3磨牙冠周炎（扁桃体及悬雍垂一般不受累）相鉴别（教材P269）。

---

120. [案例｜分析] batch040-M04-案例-005

> 模块：M04｜页码：教材P269

【CASE-M04-1】患者，28岁，男性，因急性扁桃体炎治疗5天后出现右侧咽痛加剧、吞咽困难、流涎、言语含糊不清、张口受限；查体见急性病容，右侧腭舌弓及软腭红肿隆起，悬雍垂水肿偏向左侧，右侧扁桃体被推向内下方。｜该患者若炎症扩散，可能出现的并发症包括

- **A. 咽旁脓肿** ✅
- **B. 颈部脓肿** ✅
- **C. 喉炎与喉水肿** ✅
- D. 化脓性中耳炎
- E. 心包积液

答案：ABC

> 解析：扁桃体周脓肿的炎症扩散到咽旁间隙可发生咽旁脓肿，向下蔓延可发生颈部脓肿以及喉炎、喉水肿，并出现相应症状；化脓性中耳炎、心包积液并非其直接蔓延的常见并发症（教材P269）。

M05（32题）

121. [A1型题｜记忆] batch040-M05-A1-001

> 模块：M05｜页码：教材P290

在喉的软骨支架中，构成喉气管内唯一完整环形软骨的是

- A. 甲状软骨
- **B. 环状软骨** ✅
- C. 会厌软骨
- D. 杓状软骨
- E. 小角软骨

答案：B

> 解析：环状软骨位于甲状软骨之下、第1气管环之上，前部较窄为环状软骨弓、后部较宽为环状软骨板，是喉气管中唯一完整的环形软骨，对保持喉气管的通畅至关重要，损伤后常引起喉及气管狭窄。甲状软骨是喉部最大的软骨，前方形成喉结；会厌软骨参与吞咽时的喉入口保护；杓状软骨位于环状软骨板上外缘，其声带突与声带相连；小角软骨位于杓状软骨顶部。两侧声带之间的区域称为声门区，为喉腔中最狭窄的部位（教材P290）。

---

122. [A1型题｜记忆] batch040-M05-A1-002

> 模块：M05｜页码：教材P290

成人喉的上界约平

- A. 第2～3颈椎
- B. 第3～4颈椎
- **C. 第4～5颈椎** ✅
- D. 第5～6颈椎

- E. 第6～7颈椎

答案：C

> 解析：成人喉位于颈前部，上通喉咽、下接气管，上界约平第4～5颈椎，下界约平第6颈椎。喉的支架主要由甲状软骨、环状软骨、会厌软骨及成对的杓状软骨等构成，其中甲状软骨是喉部最大的软骨，前方正中融合处形成喉结（教材P290）。

---

123. [A1型题｜记忆] batch040-M05-A1-003

> 模块：M05｜页码：教材P290

属于声带外展肌、收缩时可使声门变大的是

- A. 杓会厌肌
- B. 环杓侧肌
- C. 环甲肌
- D. 甲杓肌
- **E. 环杓后肌** ✅

答案：E

> 解析：喉内肌按功能分为5组：环杓后肌为声带外展肌，起自环状软骨板背面浅凹，收缩时使杓状软骨向外、稍向上，声带外展、声门变大；环杓侧肌和杓肌为声带内收肌，使声门闭合；环甲肌和甲杓肌为声带张力肌，调节声带紧张度；杓会厌肌收缩使会厌拉向后下方、喉入口关闭（教材P290）。

---

124. [A1型题｜记忆] batch040-M05-A1-004

> 模块：M05｜页码：教材P295

喉的淋巴以声门区为界分为两组，其中淋巴管最为丰富的是

- A. 喉前区组
- B. 声门区组
- C. 声门下区组
- **D. 声门上区组** ✅

- E. 气管前区组

答案：D

> 解析：喉的淋巴以声门区为界，分为声门上区组和声门下区组。声门上区组织中淋巴管丰富，汇集于杓会厌襞后形成较粗大的淋巴管，穿过甲舌膜与喉上动脉及静脉伴行，主要进入颈内静脉周围的颈深上淋巴结。声门区声带组织内淋巴管甚少；声门下区淋巴管较多，经环甲膜进入喉前淋巴结、气管前和气管旁淋巴结（教材P295）。

---

125. [A1型题｜记忆] batch040-M05-A1-005

> 模块：M05｜页码：教材P290

支配除环甲肌以外绝大多数喉内肌的神经是

- A. 喉上神经内支
- B. 喉上神经外支
- **C. 喉返神经** ✅
- D. 舌咽神经
- E. 迷走神经咽支

答案：C

> 解析：喉的感觉与运动主要由迷走神经的分支支配：喉上神经内支主要负责声门上区感觉，该区域感觉敏锐；喉上神经外支主要支配环甲肌；喉返神经支配除环甲肌以外的绝大多数喉内肌，并负责声门下区及声门区的重要感觉传入，损伤后可引起声带运动异常和声音嘶哑（教材P290）。

---

126. [A1型题｜理解] batch040-M05-A1-006

> 模块：M05｜页码：教材P309

急性会厌炎患者出现吸气性呼吸困难而少有声音嘶哑，其原因是

- A. 声门下黏膜肿胀
- B. 杓会厌襞黏膜肿胀
- C. 声带黏膜肿胀
- D. 会厌喉面黏膜肿胀

- **E. 会厌舌面黏膜肿胀** ✅

答案：E

> 解析：急性会厌炎又称急性声门上喉炎，会厌舌面黏膜下组织疏松，炎症时容易出现肿胀，高度肿胀时可呈球形并遮盖声门，引起吸气性呼吸困难甚至窒息；此时声带大多未受累，故很少伴有声音嘶哑。会厌喉面黏膜附着较紧密，其肿胀多不致如此显著（教材P309）。

---

127. [A1型题｜理解] batch040-M05-A1-007

> 模块：M05｜页码：教材P299

评估声带振动、黏膜波、振幅与振动对称性宜选用的检查是

- A. 间接喉镜
- **B. 频闪喉镜** ✅
- C. 电子鼻咽喉镜
- D. 支撑喉镜
- E. 硬性喉镜

答案：B

> 解析：频闪喉镜又称动态喉镜，用于评价声带振动、黏膜波、振幅和振动对称性，对声带细微病变及嗓音疾病有价值；间接喉镜可观察部分喉部及下咽，电子鼻咽喉镜可观察鼻咽、喉部及部分下咽，二者主要反映形态而非振动特性（教材P299）。

---

128. [A2型题｜应用] batch040-M05-A2-001

> 模块：M05｜页码：教材P309

男，45岁。突发剧烈咽喉痛、吞咽困难伴流涎6小时，口咽部检查黏膜充血不明显，间接喉镜见声门上区充血肿胀呈球形并遮盖声门。最可能的诊断是

- A. 急性扁桃体炎
- B. 急性喉炎
- C. 急性咽炎
- **D. 急性会厌炎** ✅

- E. 扁桃体周围脓肿

答案：D

> 解析：该患者咽喉痛剧烈、吞咽时加重并流涎，而口咽部检查仅黏膜轻度充血，呈现症状重、体征轻的特点；间接喉镜见声门上区呈球形肿胀并遮盖室带、声带，符合急性会厌炎。急性喉炎以声嘶为主，急性咽炎与急性扁桃体炎多表现为咽部弥漫充血、扁桃体充血肿大，扁桃体周围脓肿可见患侧腭弓膨隆、悬雍垂偏斜（教材P309）。

---

129. [A2型题｜应用] batch040-M05-A2-002

> 模块：M05｜页码：教材P311

男，1岁8个月。受凉后出现犬吠样咳嗽、声嘶2天，夜间加重，伴吸气性喉鸣及三凹征，无吞咽困难。最可能的诊断是

- A. 先天性喉软化症
- B. 急性喉气管支气管炎
- C. 先天性喉蹼
- D. 气管支气管异物
- **E. 小儿急性喉炎** ✅

答案：E

> 解析：小儿急性喉炎好发于6月龄至3岁儿童，多在冬春季发病，多继发于上呼吸道感染，主要症状为声嘶、犬吠样咳嗽、吸气性喉喘鸣和吸气性呼吸困难；因小儿喉腔狭小、喉部黏膜下组织疏松、咳嗽力量弱，炎症时易发生喉阻塞。该患儿声嘶、犬吠样咳嗽与吸气性呼吸困难并存，符合小儿急性喉炎；气管支气管异物有明确异物吸入史与剧烈呛咳，先天性喉蹼与喉软化症多以出生后持续吸气性喉喘鸣为特点（教材P311）。

---

130. [A2型题｜应用] batch040-M05-A2-003

> 模块：M05｜页码：教材P325

男，62岁，吸烟40年。进行性声音嘶哑6个月，伴痰中带血，喉镜检查见左侧声带中部菜花状肿物，声带活动正常。最可能的诊断是

- A. 跨声门型喉癌

- B. 声门上型喉癌
- C. 声门下型喉癌
- **D. 声门型喉癌** ✅
- E. 喉淀粉样变

答案：D

> 解析：凡年逾40岁、有吸烟或饮酒史、声嘶或咽喉部持续不适超过2周者应重视并仔细检查咽喉部。声门癌早期症状为声音改变并逐渐加重，肿瘤多原发于声带前、中1/3交界处，可呈菜花型生长。该患者中老年、长期吸烟，进行性声嘶伴痰中带血，喉镜见声带菜花状肿物，符合声门型喉癌；声门上癌早期多为咽异物感等非特异症状，声门下癌早期常有刺激性咳嗽或痰中带血而不易发现（教材P325）。

---

131. [A2型题｜理解] batch040-M05-A2-004

> 模块：M05｜页码：教材P315

女，34岁，教师。持续声嘶3个月，用声后加重；间接喉镜见双侧声带前、中1/3交界处对称性白色结节状隆起、表面光滑，发声时声门闭合不全。最可能的诊断是

- A. 喉乳头状瘤
- B. 声带息肉
- C. 声带白斑病
- D. 慢性肥厚性喉炎
- **E. 声带小结** ✅

答案：E

> 解析：声带小结多见于职业用声或用声过度者，典型位置为双侧声带前、中1/3交界处；病程长者小结呈白色结节状小的隆起、表面光滑，发声时两侧小结互相靠在一起使声门不能完全闭合。声带息肉好发于一侧或双侧声带游离缘前、中1/3处，多为半透明白色或粉红色单发肿物；声带白斑病（喉白斑病）属癌前病变，外观为白色斑块而非对称性结节（教材P315）。

---

132. [A3型题｜应用] batch040-M05-A3-001

> 模块：M05｜页码：教材P314

【M05-A3-组1】女，42岁，教师。声音嘶哑反复发作1年余，讲话费力，伴喉部干燥感及异物感，偶有喉痛；间接喉镜检查见喉黏膜弥漫充血，声带呈粉红色、边缘变钝，双声带表面可见少量黏性分泌物。无吞咽困难及颈部肿块。｜该患者最可能的诊断是

- A. 喉淀粉样变
- B. 慢性肥厚性喉炎
- C. 慢性萎缩性喉炎
- **D. 慢性单纯性喉炎** ✅
- E. 喉乳头状瘤

答案：D

> 解析：慢性喉炎临床上分为慢性单纯性喉炎、肥厚性喉炎和萎缩性喉炎。慢性单纯性喉炎喉黏膜弥漫充血，有时有轻度肿胀，声带呈粉红色、边缘变钝，声带表面有时可见分泌物并在两侧声带缘之间形成黏液丝。慢性肥厚性喉炎以室带肥厚多见，肥厚室带可遮盖部分声带；慢性萎缩性喉炎喉黏膜变薄、干燥，严重者表面有痂皮形成（教材P314）。

---

133. [A3型题｜应用] batch040-M05-A3-002

> 模块：M05｜页码：教材P314

【M05-A3-组1】女，42岁，教师。声音嘶哑反复发作1年余，讲话费力，伴喉部干燥感及异物感，偶有喉痛；间接喉镜检查见喉黏膜弥漫充血，声带呈粉红色、边缘变钝，双声带表面可见少量黏性分泌物。无吞咽困难及颈部肿块。｜该患者治疗中应优先采取的措施是

- A. 放射线照射治疗
- B. 声带息肉切除术
- C. 喉部分切除术
- D. 抗结核药物治疗
- **E. 去除病因并雾化吸入** ✅

答案：E

> 解析：慢性喉炎治疗首先应去除病因：避免长时间用声过度、戒除烟酒、改善工作环境，在粉尘环境中作业者应加强防护，并积极治疗鼻腔鼻窦的慢性炎症、解除鼻塞流涕、控制咽部及下呼吸道感染、治疗反流性食管炎；同时可予雾化吸入与中成药治疗。声带息肉切除术、喉部分切除术均非本病首选，抗结核药物与放射线照射分别针对喉结核与喉恶性肿瘤（教材P314）。

---

134. [A4型题｜应用] batch040-M05-A4-001

> 模块：M05｜页码：教材P339

【M05-A4-组1】男，3岁。发热、犬吠样咳嗽2天，今晨出现安静时吸气性呼吸困难伴喉鸣及三凹征，烦躁不安、不愿进食，脉搏加快。 ｜ 该患儿最可能的诊断及喉阻塞分度是

- A. 小儿急性喉炎Ⅰ度
- B. 小儿急性喉炎Ⅱ度
- **C. 小儿急性喉炎III度** ✅
- D. 小儿急性喉炎IV度
- E. 小儿喉痉挛III度

答案：C

> 解析：患儿以犬吠样咳嗽、吸气性喉鸣及三凹征为主要表现，符合小儿急性喉炎。喉阻塞三度表现为吸气性呼吸困难明显、喉喘鸣声较响、吸气性胸廓周围软组织凹陷显著，并出现缺氧症状，如烦躁不安、不易入睡、不愿进食、脉搏加快等。该患儿安静时即有吸气性呼吸困难并伴烦躁不安、脉搏加快，尚未出现发绀与意识障碍，故为三度（教材P339）。

---

135. [A4型题｜应用] batch040-M05-A4-002

> 模块：M05｜页码：教材P339

【M05-A4-组1】男，3岁。发热、犬吠样咳嗽2天，今晨出现安静时吸气性呼吸困难伴喉鸣及三凹征，烦躁不安、不愿进食，脉搏加快。 ｜ 若该患儿经药物治疗后呼吸困难进行性加重、全身情况较差，最恰当的处理是

- A. 立即行放射治疗
- B. 加大抗生素剂量
- C. 仅予吸氧并观察
- D. 立即行喉裂开术
- **E. 立即行气管切开术** ✅

答案：E

> 解析：喉阻塞三度由炎症引起、喉阻塞时间较短者，可在密切观察下积极使用药物治疗，并做好气管切开术的准备；若药物治疗未见好转、全身情况较差时，宜及早行气管切开术。该患儿药物治疗后呼吸困难进行性加重且全身情况较差，故应及早气管切开；单纯加大抗生素、吸氧观察或放射治疗均不能迅速解除气道梗阻（教材P339）。

---

136. [A4型题｜分析] batch040-M05-A4-003

> 模块：M05｜页码：教材P339

【M05-A4-组1】男，3岁。发热、犬吠样咳嗽2天，今晨出现安静时吸气性呼吸困难伴喉鸣及三凹征，烦躁不安、不愿进食，脉搏加快。 ｜ 该患儿若进一步出现意识障碍、面色苍白、发绀加重，与当前阶段相比提示

- A. 病情稳定无需气道干预
- B. 喉阻塞由 II 度进展为III度
- C. 喉阻塞由 I 度进展为 II 度
- D. 喉阻塞由IV度好转为III度
- **E. 喉阻塞由III度进展为IV度** ✅

答案：E

> 解析：该患儿原表现为安静时吸气性呼吸困难伴烦躁不安，属喉阻塞三度；进一步出现意识障碍、面色苍白、发绀加重，则符合四度表现，即呼吸极度困难，患者坐卧不安、手足乱动、出冷汗、面色苍白或发绀、定向力丧失、心律不齐、脉搏细数甚至昏迷，若不及时抢救可因窒息致死。IV度喉阻塞必须紧急开放气道，此时已不是保守观察的时机（教材P339）。

---

137. [判断题｜记忆] batch040-M05-判断-001

> 模块：M05｜页码：教材P290

喉任克间隙位于与声带长轴平行的黏膜下，过度发声或喉炎时易在该处形成局限性水肿。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：声带黏膜下固有层浅层为任克间隙，又称Reinke间隙，是一薄而疏松的纤维组织层，位于与声带长轴平行的黏膜下；过度发声或喉炎时易在该处造成局限性水肿，形成声带息肉（教材P290）。

---

138. [判断题｜记忆] batch040-M05-判断-002

> 模块：M05｜页码：教材P339

现场抢救IV度喉阻塞患者而无法立即行气管切开时，应首选环甲膜切开术。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：喉阻塞四度应立即行气管切开术；若病情十分紧急、来不及行常规气管切开时，可先行环甲膜切开等救命操作，待患者呼吸恢复后再行常规气管切开术。重症急性会厌炎和III～IV度喉阻塞必须优先评估和保障气道（教材P339）。

---

139. [判断题｜理解] batch040-M05-判断-003

> 模块：M05｜页码：教材P317

环甲关节炎时喉镜下可见患侧声带肌松弛，双侧病变者声门闭合时可出现梭形裂隙。

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：环甲关节炎喉镜下可见患侧声带肌松弛；如为一侧病变可出现声门偏斜，双侧环甲关节炎可引起关节活动障碍，则双侧声带肌松弛，声门闭合时有梭形裂隙。环杓关节炎则可见患侧杓区黏膜肿胀、充血，间接喉镜下喉钳触诊患侧杓区有明显触痛，严重者因环杓关节固定导致患侧声带固定（教材P317）。

---

140. [X型题｜理解] batch040-M05-X-001

> 模块：M05｜页码：教材P290

构成喉支架的软骨有

- **A. 甲状软骨** ✅
- **B. 环状软骨** ✅
- **C. 会厌软骨** ✅
- **D. 杓状软骨** ✅
- E. 舌骨

答案：ABCD

> 解析：喉的支架主要由甲状软骨、环状软骨、会厌软骨及成对的杓状软骨等构成：甲状软骨是喉部最大的软骨，前方形成喉结；环状软骨是喉气管中唯一完整的环形软骨；会厌软骨表面覆盖黏膜构成会厌，参与吞咽时的喉入口保护；杓状软骨位于环状软骨板上外缘，其声带突与声带相连。舌骨属于颈前部的舌骨，借甲状舌骨膜与喉相连，但不参与构成喉的支架软骨（教材P290）。

---

141. [X型题｜理解] batch040-M05-X-002

> 模块：M05｜页码：教材P309

急性会厌炎的临床特点有

- **A. 咽部剧痛为最典型表现** ✅
- B. 声音嘶哑为常见突出症状
- **C. 病理分型为三种类型** ✅
- **D. 气道梗阻为最严重后果** ✅
- E. 细菌培养为确诊主要依据

答案：ACD

> 解析：急性会厌炎又称急性声门上喉炎，起病急，以咽部剧痛为最典型表现，吞咽时加重，严重时唾液也难咽下；病理上分为急性卡他型、急性水肿型、急性溃疡型三种类型；声带大多未受累，故很少伴有声音嘶哑；最严重的情况是会厌肿胀导致气道梗阻，引起吸气性呼吸困难，可危及生命。对主诉剧烈咽喉痛、吞咽加重而口咽无明显异常的成人，间接喉镜见充血、肿大的会厌即可确诊，不依赖细菌培养（教材P309）。

142. [X型题｜理解] batch040-M05-X-003

> 模块：M05｜页码：教材P340

气管切开术的适应证有

- **A. Ⅱ～Ⅳ度喉阻塞** ✅
- **B. 下呼吸道分泌物潴留** ✅
- **C. 部分头颈手术的术前准备** ✅
- **D. 需长期机械通气** ✅
- E. 急性鼻炎发作期

答案：ABCD

> 解析：气管切开术的适应证涵盖Ⅱ～Ⅳ度喉阻塞、下呼吸道分泌物潴留、某些头颈手术的术前准备以及需长期机械通气的患者；常规气管切开通常选择第2～4（或第3～4）气管软骨环附近，术后需加强护理，包括定期吸痰、保持套管通畅并重视气道湿化。急性鼻炎属鼻部炎性疾病，以对症支持治疗为主，不是气管切开术的适应证（教材P340）。

---

143. [案例｜应用] batch040-M05-案例-001

> 模块：M05｜页码：教材P309

【CASE-M05-1】男，46岁。突发剧烈咽喉痛、吞咽困难伴流涎8小时，发热38.9℃。口咽部检查黏膜轻度充血，间接喉镜检查见声门上区充血肿胀呈球形并遮盖声门。入院后2小时患者出现极度呼吸困难、面色发绀、烦躁不安、手足乱动，三凹征明显。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- **A. 急性会厌炎** ✅
- B. 急性喉炎
- C. 急性咽炎
- D. 急性扁桃体炎
- E. 扁桃体周围脓肿

答案：A

> 解析：该患者咽喉痛剧烈、吞咽时加重并流涎，而口咽部检查仅黏膜轻度充血，呈现症状重、体征轻的特点；间接喉镜见声门上区呈球形肿胀并遮盖室带、声带，符合急性会厌炎。急性喉炎以声嘶为主；急性咽炎与急性扁桃体炎多表现为咽部弥漫充血、扁桃体充血肿大；扁桃体周围脓肿可见患侧软腭或腭弓膨隆、悬雍垂偏向健侧（教材P309）。

---

144. [案例｜理解] batch040-M05-案例-002

> 模块：M05｜页码：教材P339

【CASE-M05-1】男，46岁。突发剧烈咽喉痛、吞咽困难伴流涎8小时，发热38.9℃。口咽部检查黏膜轻度充血，间接喉镜检查见声门上区充血肿胀呈球形并遮盖声门。入院后2小时患者出现极度呼吸困难、面色发绀、烦躁不安、手足乱动，三凹征明显。 ｜ 该患者目前的喉阻塞临床分度是

- A. Ⅰ度喉阻塞
- B. Ⅱ度喉阻塞
- C. Ⅲ度喉阻塞
- **D. Ⅳ度喉阻塞** ✅
- E. 无喉阻塞

答案：D

> 解析：喉阻塞四度表现为呼吸极度困难，患者坐卧不安、手足乱动、出冷汗、面色苍白或发绀、定向力丧失、心律不齐、脉搏细数甚至昏迷。该患者出现极度呼吸困难、面色发绀、烦躁不安、手足乱动及明显三凹征，已符合四度喉阻塞，必须紧急开放气道，而不能仅按三度处理（教材P339）。

---

145. [案例｜理解] batch040-M05-案例-003

> 模块：M05｜页码：教材P339

【CASE-M05-1】男，46岁。突发剧烈咽喉痛、吞咽困难伴流涎8小时，发热38.9℃。口咽部检查黏膜轻度充血，间接喉镜检查见声门上区充血肿胀呈球形并遮盖声门。入院后2小时患者出现极度呼吸困难、面色发绀、烦躁不安、手足乱动，三凹征明显。 ｜ 此时对该患者最恰当的首要处理是

- A. 面罩吸氧并观察病情
- **B. 立即行气管切开术** ✅
- C. 静脉滴注抗生素

- D. 雾化吸入糖皮质激素
- E. 立即行喉裂开术

答案：B

> 解析：对急性喉阻塞患者须争分夺秒，因地制宜迅速解除呼吸困难，以免造成窒息或心力衰竭。喉阻塞四度应立即行气管切开术；若病情十分紧急时，可先行环甲膜切开术，待呼吸恢复后再行常规气管切开。单纯吸氧、抗生素或雾化吸入糖皮质激素都不能迅速解除气道梗阻；喉裂开术并非喉阻塞的常规急诊气道措施（教材P339）。

---

146. [案例｜理解] batch040-M05-案例-004

> 模块：M05｜页码：教材P340

【CASE-M05-1】男，46岁。突发剧烈咽喉痛、吞咽困难伴流涎8小时，发热38.9℃。口咽部检查黏膜轻度充血，间接喉镜检查见声门上区充血肿胀呈球形并遮盖声门。入院后2小时患者出现极度呼吸困难、面色发绀、烦躁不安、手足乱动，三凹征明显。 ｜ 该患者气道管理中应遵循的原则有

- **A. 优先评估并保障气道安全** ✅
- B. 在无气道保障时强行检查咽喉
- **C. 常规切开位置选第2～4气管软骨环** ✅
- **D. 密切观察呼吸和氧合情况** ✅
- E. 仅凭口咽外观判断病情

答案：ACD

> 解析：疑似重症急性会厌炎患者应优先评估和保障气道，避免在缺乏气道保障条件下强行刺激咽喉，以免诱发完全梗阻；须密切观察呼吸和氧合情况，并做好气管切开准备。常规气管切开通常选择第2～4（或第3～4）气管软骨环附近，术后需重视气道湿化与套管通畅。口咽部检查多无异常，不能仅凭口咽外观判断病情（教材P340）。

---

147. [案例｜记忆] batch040-M05-案例-005

> 模块：M05｜页码：教材P309

【CASE-M05-1】男，46岁。突发剧烈咽喉痛、吞咽困难伴流涎8小时，发热38.9℃。口咽部检查黏膜轻度充血，间接喉镜检查见声门上区充血肿胀呈球形并遮盖声门。入院后2小时患者出现极度呼吸困难、面色发绀、烦躁不安、手足乱动，三凹征明显。 ｜ 急性会厌炎的病理类型有

- **A. 急性卡他型** ✅
- **B. 急性水肿型** ✅
- **C. 急性溃疡型** ✅
- D. 急性增生型
- E. 急性纤维型

答案：ABC

> 解析：急性会厌炎病理上分为急性卡他型、急性水肿型与急性溃疡型三种类型：卡他型表现为会厌黏膜弥漫性充血、肿胀，因会厌舌面黏膜下组织较松弛，故舌面肿胀明显；水肿型黏膜病变以水肿为主，会厌肿胀明显时可呈球形，很容易引起喉阻塞；溃疡型少见，但病情发展迅速而严重，炎症可扩展至黏膜下层及腺体并形成溃疡（教材P309）。

---

148. [案例｜记忆] batch040-M05-案例-006

> 模块：M05｜页码：教材P325

【CASE-M05-2】男，63岁，吸烟40年。进行性声音嘶哑8个月，伴痰中带血，无咽痛。喉镜检查见左侧声带全长菜花状肿物，左侧声带固定；颈部未扪及肿大淋巴结。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- **A. 声门型喉癌** ✅
- B. 声门上型喉癌
- C. 声门下型喉癌
- D. 跨声门型喉癌
- E. 喉乳头状瘤

答案：A

> 解析：该患者中老年、长期重度吸烟，表现为持续性、进行性声音嘶哑，伴痰中带血，喉镜见声带菜花状肿物并伴声带固定，高度提示声门型喉癌。声门癌早期症状为声音改变并逐渐加重，肿瘤多原发于声带前、中1/3交界处；声门上癌早期多为咽异物感、吞咽不适等非特异症状；声门下癌临床少见，早期常有刺激性咳嗽或痰中带血；喉乳头状瘤病变多限于黏膜表层，无声带运动障碍（教材P325）。

---

149. [案例｜记忆] batch040-M05-案例-007

> 模块：M05｜页码：教材P325

【CASE-M05-2】男，63岁，吸烟40年。进行性声音嘶哑8个月，伴痰中带血，无咽痛。喉镜检查见左侧声带全长菜花状肿物，左侧声带固定；颈部未扪及肿大淋巴结。 ｜ 该部位肿瘤最常见的病理类型是

- **A. 鳞状细胞癌** ✅
- B. 腺样囊性癌
- C. 未分化癌
- D. 疣状细胞癌
- E. 小细胞癌

答案：A

> 解析：原发性喉癌中95%以上为鳞状细胞癌，是最常见的病理类型；根据发生部位可分为声门上癌、声门癌及声门下癌，其中声门癌最多见，约占60%，其次为声门上癌约占30%，声门下癌少见。该患者病变位于声带，其病理类型以鳞状细胞癌最为常见（教材P325）。

---

150. [案例｜理解] batch040-M05-案例-008

> 模块：M05｜页码：教材P325

【CASE-M05-2】男，63岁，吸烟40年。进行性声音嘶哑8个月，伴痰中带血，无咽痛。喉镜检查见左侧声带全长菜花状肿物，左侧声带固定；颈部未扪及肿大淋巴结。 ｜ 该患者声带固定提示肿瘤分期为

- A. T1期
- B. T2期
- **C. T3期** ✅
- D. T4期
- E. Tis期

答案：C

> 解析：声门型喉癌，肿瘤局限在喉内，伴有声带固定为T3期。该患者声带全长菜花状肿物并固定，颈部未扪及肿大淋巴结，病变仍局限在喉内，故属T3期；T4期提示肿瘤已穿破喉软骨侵犯喉外或颈部软组织（教材P325）。

---

151. [案例｜理解] batch040-M05-案例-009

> 模块：M05｜页码：教材P325

【CASE-M05-2】男，63岁，吸烟40年。进行性声音嘶哑8个月，伴痰中带血，无咽痛。喉镜检查见左侧声带全长菜花状肿物，左侧声带固定；颈部未扪及肿大淋巴结。 ｜ 确诊该患者所患疾病最可靠的方法是

- **A. 活组织病理检查** ✅
- B. 颈部增强CT扫描
- C. 喉部MRI增强扫描
- D. PET-CT全身显像
- E. 颈部彩色多普勒超声

答案：A

> 解析：活组织检查是喉癌确诊的金标准，可在间接喉镜、纤维（电子）鼻咽喉镜或直接喉镜下进行；因有些肿瘤表面有坏死组织或于黏膜下生长，对活检阴性而临床高度怀疑恶性者应再次活检。增强CT可明确肿瘤侵犯范围，评估喉软骨是否受侵及颈部淋巴结转移；MRI增强对软组织显示更清晰；PET-CT对发现隐匿性病变及转移有优势，但三者均不能替代病理确诊（教材P325）。

---

152. [案例｜理解] batch040-M05-案例-010

> 模块：M05｜页码：教材P325

【CASE-M05-2】男，63岁，吸烟40年。进行性声音嘶哑8个月，伴痰中带血，无咽痛。喉镜检查见左侧声带全长菜花状肿物，左侧声带固定；颈部未扪及肿大淋巴结。 ｜ 关于喉癌的治疗，下列表述正确的有

- **A. 早期喉癌可选择单一治疗方案** ✅
- **B. 中晚期喉癌需采取综合治疗** ✅
- **C. 手术治疗为喉癌治疗措施** ✅
- **D. 放射治疗为喉癌治疗措施** ✅
- E. 喉全切除术适用于早期声门癌

答案：ABCD

> 解析：喉癌治疗的主要措施包括手术、放疗、化疗、靶向、免疫以及中医药治疗；早期喉癌可选择单一的治疗方案，而中晚期喉癌则需采取综合治疗。喉全切除术适用于不适合行喉部分切除术的T3、T4期声门上癌及声门癌、声门下癌，以及放射治疗失败或复发性喉癌等，并非早期声门癌的常规术式（教材P325）。

M06（18题）

153. [A1型题｜记忆] batch040-M06-A1-001

> 模块：M06｜页码：教材P366

气管、支气管异物绝大多数发生于儿童，其中最高发的年龄段是

- **A. 3岁以下婴幼儿** ✅
- B. 3～6岁学龄前儿童
- C. 6～12岁学龄期儿童
- D. 13～18岁青少年
- E. 18岁以上成年人

答案：A

> 解析：气管、支气管异物是儿童耳鼻咽喉科最常见的急症之一，绝大多数发生于儿童，尤其以3岁以下婴幼儿多见，与3岁以下儿童磨牙未萌出、咀嚼功能不完善、吞咽协调功能和喉的保护功能不健全有关（教材P366）。

---

154. [A1型题｜理解] batch040-M06-A1-002

> 模块：M06｜页码：教材P353

气管异物更容易进入右侧主支气管，其解剖学原因是右主支气管

- A. 较长、较细、走向较水平
- B. 较短、较细、走向较水平
- **C. 较短、较粗、走向较垂直** ✅
- D. 较长、较粗、走向较垂直
- E. 较长、较细、走向较垂直

答案：C

> 解析：右主支气管较粗短，约2.5cm，与气管纵轴的延长线成20°～25°角；左主支气管细而长，约5cm，与气管纵轴的延长线约成45°角。因右侧主支气管较短、较粗、走向较垂直，气管异物更容易进入右侧主支气管（教材P353）。

---

155. [A1型题｜理解] batch040-M06-A1-003

> 模块：M06｜页码：教材P366

气管支气管异物在支气管内形成单向活瓣作用，吸气时气流可进入而呼气时受阻，此时患侧肺部最可能出现的X线表现是

- A. 患侧肺不张
- B. 患侧气胸
- C. 患侧肺脓肿
- **D. 患侧肺气肿** ✅
- E. 患侧胸腔积液

答案：D

> 解析：异物位置导致吸气时支气管腔扩大、气流可进入，而呼气时异物被呼出气流冲击将支气管腔封闭，气流只进不出，形成异物所在支气管远端的肺气肿，X线表现为患侧肺透亮度增高；若为只出不进的活瓣性阻塞或全阻塞，则形成肺不张（教材P366）。

---

156. [A1型题｜理解] batch040-M06-A1-004

> 模块：M06｜页码：教材P368

儿童疑似气管支气管异物时，胸部X线检查结果正常的临床意义是

- A. 可以排除气道异物
- **B. 不能排除气道异物** ✅
- C. 可以确诊气道异物
- D. 可以确定异物性质
- E. 可以确定异物部位

答案：B

> 解析：胸片对不透光的金属类异物可清楚显示，但对可透光异物只能显示间接征象，且许多有机异物本身不显影，故胸片正常并不能排除气道异物；儿童疑似气道异物不能因胸片正常而排除，高度怀疑时应由专科团队进一步评估（教材P368）。

---

157. [A2型题｜应用] batch040-M06-A2-001

> 模块：M06｜页码：教材P368

患儿，男，3岁，进食花生米时突发剧烈呛咳、憋气，随即面色发绀，其后出现阵发性咳嗽伴喘息，查体右肺呼吸音较左侧减弱。该患儿最可能的诊断是

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管哮喘急性发作
- **C. 气管支气管异物** ✅
- D. 支气管肺炎
- E. 小儿急性喉炎

答案：C

> 解析：该患儿为3岁以下婴幼儿，有进食坚果时突发剧烈呛咳、憋气、面色发绀的典型病史，随后阵发性咳嗽、喘息并伴患侧呼吸音减弱，符合气管、支气管异物；急性支气管炎与支气管肺炎多伴发热且起病较缓，支气管哮喘多有反复发作史及双肺弥漫哮鸣音，小儿急性喉炎以犬吠样咳嗽、声嘶和吸气性呼吸困难为主（教材P366、P368）。

---

158. [A2型题｜分析] batch040-M06-A2-002

> 模块：M06｜页码：教材P373

患者，女，58岁，误吞鱼刺后出现胸骨后疼痛，自行吞咽馒头试图将鱼刺压下，随后出现颈部皮下气肿、发热及进行性加重。上述表现提示该患者已发生

- A. 食管周围脓肿形成
- **B. 食管穿孔并发纵隔感染** ✅
- C. 食管静脉曲张破裂
- D. 食管下段癌性狭窄

- E. 反流性食管炎伴狭窄

答案：B

> 解析：尖锐异物可刺破食管壁致食管穿孔，强行吞咽馒头会进一步加重食管壁及邻近大血管损伤，潴留的食物与唾液利于细菌繁殖，感染向深部扩散形成纵隔炎；食管穿孔后咽下的空气经穿孔外溢至颈部皮下组织或纵隔，形成颈部皮下气肿或纵隔气肿，故本例最符合食管穿孔并发纵隔感染（教材P373）。

---

159. [A2型题｜应用] batch040-M06-A2-003

> 模块：M06｜页码：教材P369

患儿，女，2岁，进食瓜子后反复呛咳1周，胸部X线片示右肺透亮度增高、患侧呼吸音减弱。为取出异物，应首选的治疗方法是

- A. 局麻纤维支气管镜下取出异物
- B. 颈侧切开手术取出异物
- C. 开胸探查手术取出异物
- **D. 全麻硬性支气管镜下取出异物** ✅
- E. 抗感染治疗并继续观察

答案：D

> 解析：气管、支气管异物能自行咳出的机会很少，取出异物是唯一有效的治疗方法，应尽早取出；硬质支气管镜下异物取出适用于气管、支气管及段支气管异物，手术宜在全麻下进行，可同时完成诊断与治疗，而颈侧切开或开胸仅用于内镜无法取出的特殊情况（教材P369）。

---

160. [A3型题｜理解] batch040-M06-A3-001

> 模块：M06｜页码：教材P353

【M06-A3-组1】患儿，男，2岁，进食花生米时大笑，突发剧烈呛咳、憋气伴面色发绀，其后出现阵发性咳嗽、喘息，查体右肺呼吸音较左侧减弱，胸部X线片示右肺透亮度升高。 ｜ 结合解剖特点判断，该异物最可能位于

- A. 左侧主支气管
- **B. 右侧主支气管** ✅

- C. 气管下段
- D. 喉入口处
- E. 食管入口处

答案：B

> 解析：右侧主支气管相对较短、较粗、走向较垂直，与气管纵轴延长线的夹角较小，故气道异物更容易进入右侧主支气管；结合该患儿右肺呼吸音减弱、右肺透亮度升高，提示异物位于右侧主支气管（教材P353）。

---

161. [A4型题｜理解] batch040-M06-A4-001

> 模块：M06｜页码：教材P366

【M06-A3-组1】患儿，男，2岁，进食花生米时大笑，突发剧烈呛咳、憋气伴面色发绀，其后出现阵发性咳嗽、喘息，查体右肺呼吸音较左侧减弱，胸部X线片示右肺透亮度升高。 ｜ 该患儿胸部X线片出现右肺透亮度升高，其形成机制是

- A. 单向活瓣作用形成患侧肺不张
- B. 全阻塞作用形成患侧肺不张
- C. 全阻塞作用形成患侧肺气肿
- **D. 单向活瓣作用形成患侧肺气肿** ✅
- E. 纵隔摆动作用形成患侧肺气肿

答案：D

> 解析：异物在支气管内形成单向活瓣（只进不出的活瓣性阻塞型）时，吸气期支气管腔扩大、空气可经异物旁进入，呼气期异物被呼出气流冲击将管腔封闭，空气只进不出，远端肺内气体滞留形成患侧局限性肺气肿，X线即表现为患侧肺透亮度增高；若为全阻塞或只出不进的活瓣，则形成肺不张（教材P366）。

---

162. [判断题｜记忆] batch040-M06-判断-001

> 模块：M06｜页码：教材P366

气管、支气管异物好发于3岁以下婴幼儿

- **A. 该表述正确** ✅

- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：气管、支气管异物绝大多数发生于儿童，尤其好发于3岁以下婴幼儿，与3岁以下儿童磨牙未萌出、咀嚼功能不完善、吞咽协调功能和喉的保护功能不健全有关（教材P366）。

---

163. [判断题｜记忆] batch040-M06-判断-002

> 模块：M06｜页码：教材P354

成人食管第一处生理性狭窄（食管入口）距中切牙约25cm

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：成人食管第一处生理性狭窄即食管入口，距成人中切牙约15～16cm，是食管最狭窄的部位，异物最易嵌顿于此；25cm约为第二处狭窄即主动脉弓及左主支气管压迫区的距离，故该表述错误（教师重点第123条；教材P354）。

---

164. [X型题｜理解] batch040-M06-X-001

> 模块：M06｜页码：教材P353

关于气管、支气管的应用解剖及异物所致病理生理改变，下列叙述正确的有

- **A. 右侧主支气管较短、较粗且走向较垂直** ✅
- B. 胸片正常即可排除气道异物
- **C. 气管隆嵴约平第4～5胸椎水平** ✅
- **D. 单向活瓣阻塞可致患侧肺气肿** ✅
- **E. 全阻塞时可形成阻塞性肺不张** ✅

答案：ACDE

> 解析：右侧主支气管相对较短、较粗、走向较垂直，故异物易进入右侧；气管隆嵴位于气管分叉处，通常投影于第4～5胸椎水平附近；单向活瓣阻塞时患侧肺透亮度增高形成局限性肺气肿，全阻塞时则形成阻塞性肺不张；因许多异物不显影，胸片正常不能排除气道异物，故B错误（教材P353、P366、P368）。

---

165. [X型题｜理解] batch040-M06-X-002

> 模块：M06｜页码：教材P374

关于食管异物的处理原则，下列叙述正确的有

- **A. 应立即禁食、禁水** ✅
- B. 可吞咽饭团、馒头将异物推下
- **C. 应尽早行食管镜检查并取出异物** ✅
- D. 可饮醋使尖锐异物软化排出
- **E. 疑有穿孔者应行胃管鼻饲饮食** ✅

答案：ACE

> 解析：已明确诊断或高度怀疑食管异物时应尽早行食管镜检查并取出异物，误咽后应立即禁食、禁水；食管异物超过24小时且进食困难者术前应补液，疑有穿孔者应行胃管鼻饲饮食。严禁通过吞咽饭团、馒头或饮醋等方式强行处理异物，以免加重食管壁及邻近心脏、大血管损伤并增加致命性并发症风险，故B、D错误（教材P374）。

---

166. [案例｜应用] batch040-M06-案例-001

> 模块：M06｜页码：教材P368

【CASE-M06-1】患儿，男，2岁6个月，进食花生米时突然出现剧烈呛咳、憋气及面色发绀，约1分钟后缓解，此后反复阵发性咳嗽、喘息，活动后加重；查体见右肺呼吸音较左侧明显减弱，可闻及哮鸣音，胸部X线片示右肺透亮度增高。｜该患儿最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘急性发作
- B. 急性支气管炎
- **C. 气管支气管异物** ✅
- D. 支气管肺炎
- E. 小儿急性喉炎

答案：C

> 解析：该患儿为3岁以下婴幼儿，有进食坚果时突发剧烈呛咳、憋气、面色发绀的明确异物吸入史，其后阵发性咳嗽、喘息并伴患侧呼吸音减弱及患侧肺透亮度增高，符合气管、支气管异物的典型表现；支气管肺炎多伴发热，支气管哮喘多有反复发作史，小儿急性喉炎以犬吠样咳嗽和吸气性呼吸困难为主（教材P368）。

---

167. [案例｜记忆] batch040-M06-案例-002

> 模块：M06｜页码：教材P369

【CASE-M06-1】患儿，男，2岁6个月，进食花生米时突然出现剧烈呛咳、憋气及面色发绀，约1分钟后缓解，此后反复阵发性咳嗽、喘息，活动后加重；查体见右肺呼吸音较左侧明显减弱，可闻及哮鸣音，胸部X线片示右肺透亮度增高。 ｜ 该患儿确诊并取出异物的首选方法是

- A. 局麻下行纤维支气管镜取出
- **B. 全麻下行硬性支气管镜取出** ✅
- C. 直接喉镜下钳取异物
- D. 颈侧切开手术取出异物
- E. 开胸手术探查取出异物

答案：B

> 解析：气管、支气管异物有危及生命的可能，取出异物是唯一有效的治疗方法，儿童气道异物通常在适当麻醉和气道保障下通过硬性支气管镜确诊并取出；硬质支气管镜下异物取出手术宜在全麻下进行，而直接喉镜仅适用于喉前庭、声门区异物，颈侧切开或开胸手术仅用于内镜难以取出的特殊情况（教材P369）。

---

168. [案例｜应用] batch040-M06-案例-003

> 模块：M06｜页码：教材P369

【CASE-M06-1】患儿，男，2岁6个月，进食花生米时突然出现剧烈呛咳、憋气及面色发绀，约1分钟后缓解，此后反复阵发性咳嗽、喘息，活动后加重；查体见右肺呼吸音较左侧明显减弱，可闻及哮鸣音，胸部X线片示右肺透亮度增高。 ｜ 住院观察期间该患儿突然出现吸气性呼吸困难明显加重，伴三凹征及烦躁不安，此时应首选的处理是

- A. 立即口服镇咳药物并观察

- B. 立即复查胸部X线片
- C. 立即静脉输注抗生素
- D. 立即安排择期支气管镜检查
- **E. 立即开放气道并紧急取出异物** ✅

答案：E

> 解析：气管、支气管异物随时可造成窒息而威胁生命，异物在气道内活动并引起呼吸困难时应立即手术取出，并发肺炎或心力衰竭者需先控制并发症；出现吸气性呼吸困难加重伴三凹征时，保持气道通畅并紧急取出异物为最恰当的处理，复查胸片、镇咳或抗生素治疗均不能解除气道梗阻（教材P369）。

---

169. [案例｜理解] batch040-M06-案例-004

> 模块：M06｜页码：教材P366

【CASE-M06-1】患儿，男，2岁6个月，进食花生米时突然出现剧烈呛咳、憋气及面色发绀，约1分钟后缓解，此后反复阵发性咳嗽、喘息，活动后加重；查体见右肺呼吸音较左侧明显减弱，可闻及哮鸣音，胸部X线片示右肺透亮度增高。 ｜ 该患儿吸入的花生米属于植物性异物，其对气道黏膜的主要危害特点是

- A. 体积细小不易嵌顿
- B. 表面光滑不易损伤黏膜
- C. X线检查易于显影定位
- **D. 含游离脂肪酸刺激性强** ✅
- E. 不易引起炎性反应

答案：D

> 解析：按异物种类与性质可分为植物性、动物性、金属性及化学合成品等，植物性异物如花生、豆类含游离脂肪酸，对气道黏膜刺激性强，可引起严重的呼吸道黏膜急性弥漫性炎症反应，临床上称植物性气管支气管炎；而玻璃、不锈钢与合金等异物刺激较小，病理反应较轻（教材P366）。

---

170. [案例｜记忆] batch040-M06-案例-005

> 模块：M06｜页码：教材P370

【CASE-M06-1】患儿，男，2岁6个月，进食花生米时突然出现剧烈呛咳、憋气及面色发绀，约1分钟后缓解，此后反复阵发性咳嗽、喘息，活动后加重；查体见右肺呼吸音较左侧明显减弱，可闻及哮鸣音，胸部X线片示右肺透亮度增高。 ｜ 该患儿出院时，向家长强调预防气道异物的正确做法有

- **A. 避免给3岁以下儿童吃花生、瓜子** ✅
- **B. 进食时避免嬉笑、哭闹、打骂** ✅
- C. 小儿哭闹时喂食坚果以安抚
- **D. 教育儿童不要口含玩具玩耍** ✅
- **E. 加强对昏迷及全麻患者的护理** ✅

答案：ABDE

> 解析：呼吸道异物是最常见的儿童意外伤害之一，也是完全可以预防的疾病。预防要点包括避免给3岁以下儿童吃花生、瓜子、豆类等坚果类食物，口含食物或进食时应避免嬉笑、哭闹、打骂，教育儿童不要口含食物或玩具玩耍，并加强对昏迷及全麻患者的护理以防止呕吐物误吸入下呼吸道；在哭闹时喂食坚果反而增加误吸风险，故C错误（教材P370）。

M07（30题）

171. [A1型题｜记忆] batch040-M07-A1-001

> 模块：M07｜页码：教材P383

颈深筋膜中，包绕胸锁乳突肌和斜方肌的是

- **A. 封套筋膜** ✅
- B. 内脏筋膜
- C. 椎前筋膜
- D. 颈浅筋膜
- E. 椎后筋膜

答案：A

> 解析：颈深筋膜由浅入深分为封套筋膜、内脏筋膜和椎前筋膜三层：封套筋膜为浅层，包绕胸锁乳突肌和斜方肌；内脏筋膜为中层，包绕气管、食管、甲状腺等内脏结构；椎前筋膜为深层，覆盖颈椎前方肌群及深层结构。颈浅筋膜与椎后筋膜均不属于颈深筋膜的标准分层（教材P383）。

---

172. [A1型题｜记忆] batch040-M07-A1-002

> 模块：M07｜页码：教材P385

行颈淋巴结清扫处理颌下淋巴结区域时，应注意保护的面神经分支是

- **A. 面神经下颌缘支** ✅
- B. 面神经颞支
- C. 面神经颧支
- D. 面神经颊支
- E. 面神经颈支

答案：A

> 解析：面神经出茎乳孔后进入腮腺，分为颞支、颧支、颊支、下颌缘支和颈支。下颌缘支支配下唇肌群，走行于下颌下腺及颌下淋巴结区域附近，处理该区域时应予保护，以免术后出现口角歪斜。颞支、颧支、颊支、颈支分别主要支配额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌及颈阔肌（教材P385）。

---

173. [A1型题｜记忆] batch040-M07-A1-003

> 模块：M07｜页码：教材P386

临床上所称的 Virchow 淋巴结，其经典位置是

- **A. 左侧锁骨上** ✅
- B. 右侧锁骨上
- C. 左侧颈后三角
- D. 右侧颈后三角
- E. 双侧颌下区

答案：A

> 解析：Virchow 淋巴结经典上指左侧锁骨上淋巴结，位于胸导管汇入左静脉角附近，其肿大可能提示胃肠道等胸腹部恶性肿瘤转移；右侧锁骨上、颈后三角及颌下区淋巴结均非该淋巴结的经典位置（教材P386）。

---

174. [A1型题｜理解] batch040-M07-A1-004

> 模块：M07｜页码：教材P392

对成人性质不明且怀疑恶性的颈部肿块，首选的初步病理取材方式是

- **A. 细针穿刺抽吸活检** ✅
- B. 切开皮肤活检
- C. 完整肿块切除术
- D. 切取部分肿块活检
- E. 颈部淋巴结清扫术

答案：A

> 解析：对性质不明且怀疑恶性的成人颈部肿块，细针穿刺抽吸活检（FNAB）创伤小、简便易行，是重要的初步病理取材方式，不宜常规直接进行开放性切除活检；完整切除活检一般用于穿刺阴性而临床仍不能排除恶性者。切开皮肤活检、切取部分肿块活检及颈部淋巴结清扫术均非首选（教材P392）。

---

175. [A1型题｜记忆] batch040-M07-A1-005

> 模块：M07｜页码：教材P398

颈动脉体瘤的典型解剖位置是

- **A. 颈总动脉分叉处** ✅
- B. 颈内动脉起始部
- C. 胸锁乳突肌后缘
- D. 下颌下腺深面
- E. 甲状腺侧叶后方

答案：A

> 解析：颈动脉体瘤为发生于颈总动脉分叉处的化学感受器肿瘤，多位于颈动脉三角区、下颌角下方，生长缓慢。颈内动脉起始部、胸锁乳突肌后缘、下颌下腺深面及甲状腺侧叶后方均非其典型部位（教材P398）。

---

176. [A1型题｜记忆] batch040-M07-A1-006

> 模块：M07｜页码：教材P398

颈动脉体瘤的典型触诊特点是

- **A. 横向活动好而上下活动受限** ✅
- B. 上下活动好而横向活动受限
- C. 横向与上下活动均受限
- D. 横向与上下活动均不受限
- E. 随吞咽动作上下移动

答案：A

> 解析：颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处并将颈内、外动脉推开，故肿块左右（横向）活动度较大而上下活动受限，浅表可扪及血管搏动，有时可闻及血管杂音。上下活动好而横向受限、两者均受限或均不受限均不符合；随吞咽动作上下移动多见于甲状舌管囊肿（教材P398）。

---

177. [A2型题｜应用] batch040-M07-A2-001

> 模块：M07｜页码：教材P393

男，8岁。颈部正中线处发现一圆形囊性肿物2年，边界清楚、表面光滑，随吞咽及伸舌动作上下移动，无红肿及压痛。该患儿最可能的诊断是

- **A. 甲状舌管囊肿** ✅
- B. 第二鳃裂囊肿
- C. 颈动脉体瘤
- D. 颈部转移癌
- E. 颈部淋巴结炎

答案：A

> 解析：该患儿肿物位于颈前正中线，呈囊性、边界清楚，随吞咽及伸舌动作上下移动，为甲状舌管囊肿的典型表现。第二鳃裂囊肿多位于胸锁乳突肌前缘附近；颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处且横向活动好而上下活动受限；颈部转移癌多见于中老年、质硬固定；颈部淋巴结炎多伴红肿热痛（教材P393）。

---

178. [A2型题｜理解] batch040-M07-A2-002

> 模块：M07｜页码：教材P393

女，12岁。出生后即见左颈下部胸锁乳突肌前缘一瘘口，间断流出黏液样分泌物，无红肿及疼痛。该患儿最可能的诊断是

- **A. 第二鳃裂瘘管** ✅
- B. 甲状舌管瘘管
- C. 颈动脉体瘤
- D. 颈部淋巴结结核
- E. 颈部转移癌

答案：A

> 解析：该患儿瘘口位于胸锁乳突肌前缘，间断流出黏液样分泌物且自出生即存在，符合第二鳃裂囊肿及瘘管，属胚胎期鳃沟发育异常所致的先天性疾病，占鳃裂异常的大多数。甲状舌管瘘管多位于颈前正中线；颈动脉体瘤为搏动性肿块；颈部淋巴结结核常形成寒性脓肿及瘘管并伴全身症状；颈部转移癌多见于中老年（教材P393）。

---

179. [A2型题｜应用] batch040-M07-A2-003

> 模块：M07｜页码：教材P404

男，62岁，吸烟饮酒史40年。右颈部无痛性肿块3个月，质硬、固定、进行性增大。最应首先考虑的诊断是

- **A. 颈部转移癌** ✅
- B. 颈部淋巴瘤
- C. 颈部神经鞘瘤
- D. 颈部血管瘤
- E. 颈部淋巴结结核

答案：A

> 解析：中老年男性、有长期吸烟饮酒史，颈部出现无痛、质硬、固定并呈进行性增大的肿块，应首先考虑颈部转移癌并积极查找原发灶。颈部淋巴瘤多为多部位淋巴结肿大并可伴发热；颈部神经鞘瘤多较硬、可伴沿神经放射的麻木感；颈部血管瘤多质软、可压缩；颈部淋巴结结核多伴结核中毒症状及寒性脓肿（教材P404）。

180. [A2型题｜应用] batch040-M07-A2-004

> 模块：M07｜页码：教材P398

女，45岁。左颈上部无痛性肿块2年，质韧，横向推动度较好而上下推动受限，局部听诊可闻及血管杂音。最可能的诊断是

- **A. 颈动脉体瘤** ✅
- B. 颈内动脉瘤
- C. 颈部神经鞘瘤
- D. 颈部淋巴结炎
- E. 第二鳃裂囊肿

答案：A

> 解析：该患者肿块位于颈上部、无痛、质韧，横向活动好而上下活动受限，并可闻及血管杂音，符合颈动脉体瘤的典型表现。颈内动脉瘤亦为搏动性肿块，但多呈膨胀性搏动、无明显横向活动优势；颈部神经鞘瘤质硬、活动度小并可伴神经放射痛；颈部淋巴结炎常伴红肿热痛；第二鳃裂囊肿多位于胸锁乳突肌前缘且质软、无血管杂音（教材P398）。

---

181. [A2型题｜理解] batch040-M07-A2-005

> 模块：M07｜页码：教材P404

男，50岁。左耳闷塞感伴回吸性涕血3个月，查体左颈深上触及无痛、质硬、活动度差的肿大淋巴结，鼻咽镜见鼻咽部溃疡型肿物。最可能的情况是

- **A. 鼻咽癌伴颈淋巴结转移** ✅
- B. 鼻咽炎伴颈淋巴结炎
- C. 鼻咽结核伴颈淋巴结肿大
- D. 鼻腔淋巴瘤伴颈淋巴结肿大
- E. 鼻咽纤维血管瘤伴颈淋巴结转移

答案：A

> 解析：鼻咽癌好发于咽隐窝，常以耳部症状（耳闷、听力下降）及回吸性涕血为表现，颈部淋巴结转移多先至颈深上 II 区，特点为无痛、质硬、边界不清、活动度差。鼻咽炎及鼻咽结核多无溃疡型肿物及无痛质硬淋巴结；鼻腔淋巴瘤多伴多部位淋巴结肿大及发热；鼻咽纤维血管瘤多见于青少年男性、反复鼻出血且一般无颈淋巴结转移（教材P404）。

---

182. [A3型题｜应用] batch040-M07-A3-001

> 模块：M07｜页码：教材P393

【M07-A3-组1】男，9岁。家长发现其颈前正中线处一囊性肿物2年，肿物边界清楚、表面光滑，随吞咽及伸舌动作上下移动，无红肿及压痛，无呼吸困难及吞咽困难。 ｜ 该患儿最可能的诊断是

- **A. 甲状舌管囊肿** ✅
- B. 第二鳃裂囊肿
- C. 颈动脉体瘤
- D. 颈部转移癌
- E. 颈部淋巴结炎

答案：A

> 解析：该患儿肿物位于颈前正中线、呈囊性、边界清楚，随吞咽及伸舌动作上下移动，为甲状舌管囊肿的典型表现。第二鳃裂囊肿多位于胸锁乳突肌前缘附近；颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处；颈部转移癌多见于中老年、质硬固定；颈部淋巴结炎多伴红肿热痛（教材P393）。

---

183. [A3型题｜理解] batch040-M07-A3-002

> 模块：M07｜页码：教材P393

【M07-A3-组1】男，9岁。家长发现其颈前正中线处一囊性肿物2年，肿物边界清楚、表面光滑，随吞咽及伸舌动作上下移动，无红肿及压痛，无呼吸困难及吞咽困难。 ｜ 该病的经典手术方式为 Sistrunk 术，该术式要求一并切除的结构是

- **A. 舌骨中段及舌盲孔周围组织** ✅
- B. 全部舌骨及舌根组织
- C. 患侧甲状腺组织及峡部
- D. 胸锁乳突肌及深面筋膜
- E. 下颌下腺及颌下淋巴结

答案：A

> 解析：甲状舌管囊肿的经典手术为 Sistrunk 术，除切除囊肿及瘘管外，还需一并切除舌骨中段及舌盲孔周围组织，以清除可能残存的甲状舌管上皮、减少复发；单纯摘除囊肿复发率高。切除全部舌骨、患侧甲状腺、胸锁乳突肌及下颌下腺等均超出该术式范围（教材P393）。

---

184. [A4型题｜应用] batch040-M07-A4-001

> 模块：M07｜页码：教材P398

【M07-A4-组1】女，48岁。左颈部无痛性肿块3年，缓慢增大。查体：肿物位于下颌角下方、颈总动脉分叉水平，质韧，左右推动度较好而上下推动受限，局部可闻及血管性杂音，无压痛。 ｜ 该患者最可能的诊断是

- **A. 颈动脉体瘤** ✅
- B. 颈内动脉瘤
- C. 颈部神经鞘瘤
- D. 颈部淋巴结炎
- E. 第二鳃裂囊肿

答案：A

> 解析：该患者肿块位于下颌角下方、颈总动脉分叉水平，质韧，左右推动度较好而上下推动受限，局部可闻及血管性杂音，符合颈动脉体瘤的典型表现。颈内动脉瘤多呈膨胀性搏动而无明显横向活动优势；颈部神经鞘瘤质硬、活动度小并可伴神经放射痛；颈部淋巴结炎多伴红肿热痛；第二鳃裂囊肿多质软、无血管杂音（教材P398）。

---

185. [A4型题｜理解] batch040-M07-A4-002

> 模块：M07｜页码：教材P398

【M07-A4-组1】女，48岁。左颈部无痛性肿块3年，缓慢增大。查体：肿物位于下颌角下方、颈总动脉分叉水平，质韧，左右推动度较好而上下推动受限，局部可闻及血管性杂音，无压痛。 ｜ 若对该肿块行数字减影血管造影（DSA）检查，最可能显示的特征性征象是

- **A. 颈动脉分叉呈高脚杯样增宽** ✅
- B. 颈动脉分叉管腔节段性狭窄
- C. 颈动脉分叉内膜片状撕裂

- D. 颈动脉分叉管壁广泛钙化
- E. 颈动脉分叉血流突然中断

答案：A

> 解析：颈动脉体瘤富含血管，位于颈总动脉分叉处并将颈内、外动脉推开，DSA 可见颈动脉分叉增宽、肿瘤富含血管而呈典型的“高脚杯”样表现。管腔节段性狭窄、内膜片状撕裂、管壁广泛钙化及血流突然中断分别见于动脉粥样硬化、动脉夹层、血管钙化及血栓闭塞等病变（教材P398）。

---

186. [A4型题｜应用] batch040-M07-A4-003

> 模块：M07｜页码：教材P398

【M07-A4-组1】女，48岁。左颈部无痛性肿块3年，缓慢增大。查体：肿物位于下颌角下方、颈总动脉分叉水平，质韧，左右推动度较好而上下推动受限，局部可闻及血管性杂音，无压痛。｜对该高度怀疑的肿物，诊治中首先应避免的操作是

- **A. 直接穿刺活检** ✅
- B. 颈部彩色多普勒超声
- C. 颈部增强CT扫描
- D. 颈部血管造影检查
- E. 短期间隔随访观察

答案：A

> 解析：颈动脉体瘤血供丰富，怀疑该病时必须先行影像学评估，不应盲目穿刺或活检，以免引起严重出血。颈部彩色多普勒超声、增强CT及血管造影均可用于评估肿块与颈动脉分叉的关系；对诊断不明的颈部肿块也不宜消极随访（教材P398）。

---

187. [判断题｜理解] batch040-M07-判断-001

> 模块：M07｜页码：教材P386

咽后淋巴结属于 Robbins 颈部淋巴结分区中的颈前中央区（VI区）

- A. 该表述正确
- **B. 该表述错误** ✅

答案：B

> 解析：Robbins 分区中，VI区为颈前中央区，主要包括喉前、气管前和气道旁淋巴结；咽后淋巴结不属于VI区。颈部淋巴结分区对头颈部恶性肿瘤的临床分期、手术清扫范围及放疗靶区设计具有重要意义，故该表述错误（教材P386）。

---

188. [判断题｜记忆] batch040-M07-判断-002

> 模块：M07｜页码：教材P393

第二鳃裂囊肿或瘘管常位于胸锁乳突肌前缘附近，属于先天性发育异常

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：第二鳃裂囊肿及瘘管由胚胎期鳃沟闭合不全引起，属先天性发育异常，大多数外瘘口位于胸锁乳突肌前缘附近，可表现为侧颈囊性肿块或反复流出黏液的瘘口，感染时可红肿疼痛，故该表述正确（教材P393）。

---

189. [判断题｜理解] batch040-M07-判断-003

> 模块：M07｜页码：教材P404

成人出现持续性、质硬、固定并呈进行性增大的颈部肿块时，应优先排查恶性肿瘤

- **A. 该表述正确** ✅
- B. 该表述错误

答案：A

> 解析：成人持续性、质硬、固定或进行性增大的颈部肿块，尤其伴吸烟饮酒史、体重下降等可疑症状时，应优先排查恶性肿瘤，并根据情况安排增强CT或MRI、上呼吸消化道内镜检查及病理取材；儿童颈部肿块则以先天性疾病和脉管瘤居多，故该表述正确（教材P404）。

---

190. [X型题｜记忆] batch040-M07-X-001

> 模块：M07｜页码：教材P383

颈深筋膜通常分为若干层次，下列属于颈深筋膜组成的有

- **A. 封套筋膜** ✅
- **B. 内脏筋膜** ✅
- **C. 椎前筋膜** ✅
- D. 颈浅筋膜
- E. 椎后筋膜

答案：ABC

> 解析：颈深筋膜由浅入深分为封套筋膜、内脏筋膜和椎前筋膜三层，分别包绕胸锁乳突肌与斜方肌、气管食管甲状腺等内脏结构以及颈椎前方肌群；颈浅筋膜与椎后筋膜均不属于颈深筋膜的标准分层（教材P383）。

---

191. [X型题｜记忆] batch040-M07-X-002

> 模块：M07｜页码：教材P386

关于 Robbins 颈部淋巴结分区及颈部淋巴结引流，下列描述正确的有

- **A. Ⅰ区包括颏下区与下颌下区** ✅
- **B. Ⅱ～Ⅳ区分别为颈内静脉上、中、下组** ✅
- **C. Ⅵ区主要包括喉前、气管前及气管旁淋巴结** ✅
- D. 咽后淋巴结属于颈前中央Ⅵ区
- **E. Virchow 淋巴结指左侧锁骨上淋巴结** ✅

答案：ABCE

> 解析：Robbins 分区中Ⅰ区包括颏下区与下颌下区，Ⅱ～Ⅳ区分别为颈内静脉上、中、下组，Ⅵ区为颈前中央区、主要包括喉前、气管前和气道旁淋巴结；咽后淋巴结不属于Ⅵ区，故 D 错误。Virchow 淋巴结指左侧锁骨上淋巴结，其肿大可能提示胃肠道等胸腹部恶性肿瘤转移（教材P386）。

---

192. [X型题｜理解] batch040-M07-X-003

> 模块：M07｜页码：教材P389

关于颈部肿块的检查与诊断，下列描述正确的有

- **A. 颈部彩色多普勒超声可初步评估肿块大小、边界、囊实性及血流** ✅
- **B. 细针穿刺抽吸活检是判断颈部肿块病理性质的常用方法** ✅
- **C. 不能单凭血流信号直接断定肿块的良恶性** ✅
- D. 性质不明的可疑恶性肿块可常规直接行开放切除活检
- **E. 超声引导下细针穿刺可提高取材准确率** ✅

答案：ABCE

> 解析：颈部彩色多普勒超声可初步评估肿块的大小、囊实性、边界及血流，并可辅助超声引导下细针穿刺；细针穿刺抽吸活检（FNAB）微创、简便，是判断颈部肿块病理性质的常用方法；不能单凭血流信号直接断定肿块良恶性。对性质不明且怀疑恶性的肿块不宜常规直接行开放切除活检，故 D 错误（教材P389）。

---

193. [X型题｜理解] batch040-M07-X-004

> 模块：M07｜页码：教材P393

关于颈部先天性疾病，下列描述正确的有

- **A. 甲状舌管囊肿典型位于颈前正中线** ✅
- **B. 甲状舌管囊肿常随吞咽及伸舌运动上下移动** ✅
- **C. 第二鳃裂囊肿或瘘管常位于胸锁乳突肌前缘附近** ✅
- D. 第二鳃裂瘘管属于后天获得性病变
- **E. 甲状舌管囊肿的经典手术为 Sistrunk 术** ✅

答案：ABCE

> 解析：甲状舌管囊肿由胚胎期甲状舌管退化不全引起，典型位于颈前正中线，常随吞咽及伸舌运动上下移动，经典手术为 Sistrunk 术；第二鳃裂囊肿或瘘管由鳃沟闭合不全引起，属先天性发育异常，常位于胸锁乳突肌前缘附近，故 D 错误（教材P393）。

---

194. [X型题｜理解] batch040-M07-X-005

> 模块：M07｜页码：教材P398

关于颈动脉体瘤，下列描述正确的有

- **A. 多位于颈总动脉分叉处** ✅
- **B. 属于血供丰富的良性肿瘤** ✅
- **C. 典型表现为侧颈部无痛性肿块** ✅
- **D. 血管造影可显示颈动脉分叉呈高脚杯样增宽** ✅
- E. 确诊前可常规行肿物穿刺活检以明确病理

答案：ABCD

> 解析：颈动脉体瘤为发生在颈总动脉分叉处的化学感受器肿瘤，属血供丰富的良性肿瘤，典型表现为侧颈部无痛性肿块、横向活动好而上下活动受限，血管造影可见颈动脉分叉呈高脚杯样增宽。由于血供丰富，怀疑该病时应谨慎决定是否穿刺，不可常规穿刺活检，故 E 错误（教材P398）。

---

195. [X型题｜记忆] batch040-M07-X-006

> 模块：M07｜页码：教材P404

关于颈部转移癌及其可能原发灶，下列描述正确的有

- **A. 中老年患者出现无痛、质硬、固定、进行性增大的颈部肿块应警惕转移癌** ✅
- **B. 鼻咽癌颈部淋巴结转移多先至颈深上 II 区** ✅
- **C. 下咽癌与喉癌均可转移至颈部淋巴结** ✅
- **D. 甲状腺癌可转移至中央区及侧颈区淋巴结** ✅
- E. 胃肠道肿瘤多转移至右侧锁骨上淋巴结

答案：ABCD

> 解析：中老年患者颈部无痛、质硬、固定、进行性增大的肿块应警惕转移癌并查找原发灶；鼻咽癌颈部淋巴结转移多先至颈深上 II 区；下咽癌、喉癌可转移至颈部淋巴结；甲状腺癌可转移至中央区及侧颈区淋巴结；胃肠道等胸腹部肿瘤多经胸导管转移至左侧锁骨上 Virchow 淋巴结，而非右侧，故 E 错误（教材P404）。

---

196. [案例｜应用] batch040-M07-案例-001

> 模块：M07｜页码：教材P404

【CASE-M07-1】男，58岁，吸烟30年、饮酒20年。右颈部无痛性肿块6个月，逐渐增大，无红肿及压痛。查体：右颈深上区触及约3cm×2cm肿块，质硬、边界欠清、活动度差；另于右上颈、下颌角下方触及一质韧搏动性肿块，横向推动度较好而上下推动受限，听诊可闻及血管杂音。鼻咽镜检查见鼻咽部菜花状肿物，表面糜烂易出血。 ｜ 该患者右颈深上区质硬、活动度差且进行性增大的肿块，最应首先考虑的是

- **A. 颈部转移癌** ✅
- B. 颈部淋巴瘤
- C. 颈部神经鞘瘤
- D. 颈部血管瘤
- E. 颈部淋巴结结核

答案：A

> 解析：该患者中老年、有长期吸烟饮酒史，右颈深上区肿块无痛、质硬、边界欠清、活动度差且进行性增大，符合颈部转移癌的典型表现，应进一步查找原发灶。颈部淋巴瘤多为多部位淋巴结肿大并可伴发热；颈部神经鞘瘤可伴沿神经放射的麻木感；颈部血管瘤多质软、可压缩；颈部淋巴结结核多伴结核中毒症状及寒性脓肿（教材P404）。

---

197. [案例｜理解] batch040-M07-案例-002

> 模块：M07｜页码：教材P386

【CASE-M07-1】男，58岁，吸烟30年、饮酒20年。右颈部无痛性肿块6个月，逐渐增大，无红肿及压痛。查体：右颈深上区触及约3cm×2cm肿块，质硬、边界欠清、活动度差；另于右上颈、下颌角下方触及一质韧搏动性肿块，横向推动度较好而上下推动受限，听诊可闻及血管杂音。鼻咽镜检查见鼻咽部菜花状肿物，表面糜烂易出血。 ｜ 若该淋巴结确为癌转移，其最可能首先累及的颈部分区是

- **A. 颈深上Ⅱ区** ✅
- B. 颈深上Ⅲ区
- C. 颈深下Ⅳ区
- D. 颈后三角Ⅴ区
- E. 颈前中央Ⅵ区

答案：A

> 解析：头颈部肿瘤的颈部淋巴结转移多沿颈内静脉淋巴结链发展，鼻咽癌颈部淋巴结转移多先至颈深上Ⅱ区（即颈内静脉上组），故该分区最可能首先受累。Ⅲ区为颈内静脉中组、Ⅳ区为颈内静脉下组，Ⅴ区为颈后三角，Ⅵ区为颈前中央区，均非鼻咽癌首先累及的区域（教材P386）。

---

198. [案例｜应用] batch040-M07-案例-003

> 模块：M07｜页码：教材P398

【CASE-M07-1】男，58岁，吸烟30年、饮酒20年。右颈部无痛性肿块6个月，逐渐增大，无红肿及压痛。查体：右颈深上区触及约3cm×2cm肿块，质硬、边界欠清、活动度差；另于右上颈、下颌角下方触及一质韧搏动性肿块，横向推动度较好而上下推动受限，听诊可闻及血管杂音。鼻咽镜检查见鼻咽部菜花状肿物，表面糜烂易出血。 ｜ 对该患者右上颈部搏动性肿块，诊治中首先应避免的操作是

- **A. 直接穿刺活检** ✅
- B. 颈部彩色多普勒超声
- C. 颈部增强CT扫描
- D. 颈部血管造影检查
- E. 定期门诊随访观察

答案：A

> 解析：该搏动性肿块位于颈总动脉分叉水平、可闻及血管杂音，高度提示颈动脉体瘤，因血供丰富，必须先行影像学评估，不应盲目穿刺或活检，以免引起严重出血。颈部彩色多普勒超声、增强CT及血管造影均可用于评估肿块与颈动脉分叉的关系；对性质不明的肿块也不宜单纯消极随访（教材P398）。

---

199. [案例｜理解] batch040-M07-案例-004

> 模块：M07｜页码：教材P398

【CASE-M07-1】男，58岁，吸烟30年、饮酒20年。右颈部无痛性肿块6个月，逐渐增大，无红肿及压痛。查体：右颈深上区触及约3cm×2cm肿块，质硬、边界欠清、活动度差；另于右上颈、下颌角下方触及一质韧搏动性肿块，横向推动度较好而上下推动受限，听诊可闻及血管杂音。鼻咽镜检查见鼻咽部菜花状肿物，表面糜烂易出血。 ｜ 为评估该颈部肿块与颈动脉分叉及周围结构的关系，最合适的检查是

- **A. 颈部增强CT或MRI** ✅

- B. 颈部X线平片检查
- C. 颈部超声心动图
- D. 胸部X线平片检查
- E. 腹部彩色多普勒超声

答案：A

> 解析：彩色多普勒超声及增强CT或MRI可判断肿块与颈动脉分叉及周围结构的关系，血管造影还可显示肿瘤推开颈动脉分叉形成高脚杯征。颈部X线平片、超声心动图、胸部X线平片及腹部彩色多普勒超声均不能满意评估颈部肿块与颈动脉分叉的解剖关系（教材P398）。

---

200. [案例｜分析] batch040-M07-案例-005

> 模块：M07｜页码：教材P404

【CASE-M07-1】男，58岁，吸烟30年、饮酒20年。右颈部无痛性肿块6个月，逐渐增大，无红肿及压痛。查体：右颈深上区触及约3cm×2cm肿块，质硬、边界欠清、活动度差；另于右上颈、下颌角下方触及一质韧搏动性肿块，横向推动度较好而上下推动受限，听诊可闻及血管杂音。鼻咽镜检查见鼻咽部菜花状肿物，表面糜烂易出血。 ｜ 综合上述情况，该患者下一步最适合的处理是

- **A. 先明确病理性质再定方案** ✅
- B. 立即行颈部肿块完整切除
- C. 立即行颈部放射治疗
- D. 经验性抗结核治疗
- E. 口服抗生素后观察

答案：A

> 解析：对性质不明且怀疑恶性的成人颈部肿块，应先行细针穿刺抽吸活检等病理取材，必要时结合鼻咽镜活检及增强CT或MRI查找原发灶，再据结果制定治疗方案，不宜常规直接行开放性切除活检；对高度怀疑的血管性肿块更应先行影像学评估、避免盲目穿刺。立即完整切除、立即放疗、经验性抗结核或单纯口服抗生素观察均缺乏病理依据（教材P404）。
